

浙江省第十八届“挑战杯”课外学术科技作品竞赛

数“智”赋能下的心理健康 教育服务新模式

——基于浙江百县千校的调研



项目背景

极端案例，轰动全国



“成都49中学生坠亡事件” “少年胡鑫宇失踪事件”

儿童青少年心理健康事件频发，对家庭和社会造成巨大伤害

每100名学生中，就有 **14** 名学生受
心理健康问题困扰



初二学生留遗书从学校6楼跳下身亡 家长质疑生前遭罚跪/体...
2022年12月10日 浙江温州一名初二学生中午时分留遗书后，从学校6楼跳下经抢救无效身亡。事发后，家长查看了监控视频，称他生前在教室里遭罚跪，质疑他的死亡与罚跪有关。2月3...

浙江两名小学生因被家长“放鸽子”，欲跳楼自杀 被劝阻



2021年4月12日 4月9日，浙江温州两名小学生因家长爽约欲跳楼自杀，消防、老师以及家长对方劝阻才避免了一场悲剧发生。据了解，这两名小学生今年上五年级，因为家长曾答应过陪她们到对方家玩，结...

紧急提醒！涉及浙江多名学生！最小13岁

2023年2月9日 据宁波公安今天发布提醒，近日已有8位学生，最小的13岁，因向诈骗引流人员提供个人手机卡，被公安机关处理！1 真实案例：宁波15岁的王某，在“游戏APP”上打游戏，结...

痛心！温州11岁学生跳楼！疑学习压力太大 腾讯新闻



2022年11月8日 据评论区网友称，该名11岁学生，是瑞安某实验小学四年级学生，坠楼原因疑似考试成绩不理想，被父母批评后，一时难以接受，导致孩子轻生跳楼。在诸多评论区网友的讨论中，“鸡娃教育”似乎...

数据来源：《2022国民健康洞察报告》

探索实践

针对心理健康现状，开展案例访谈，实地调研浙江省90区县



深度访谈126起自杀案例
了解现状



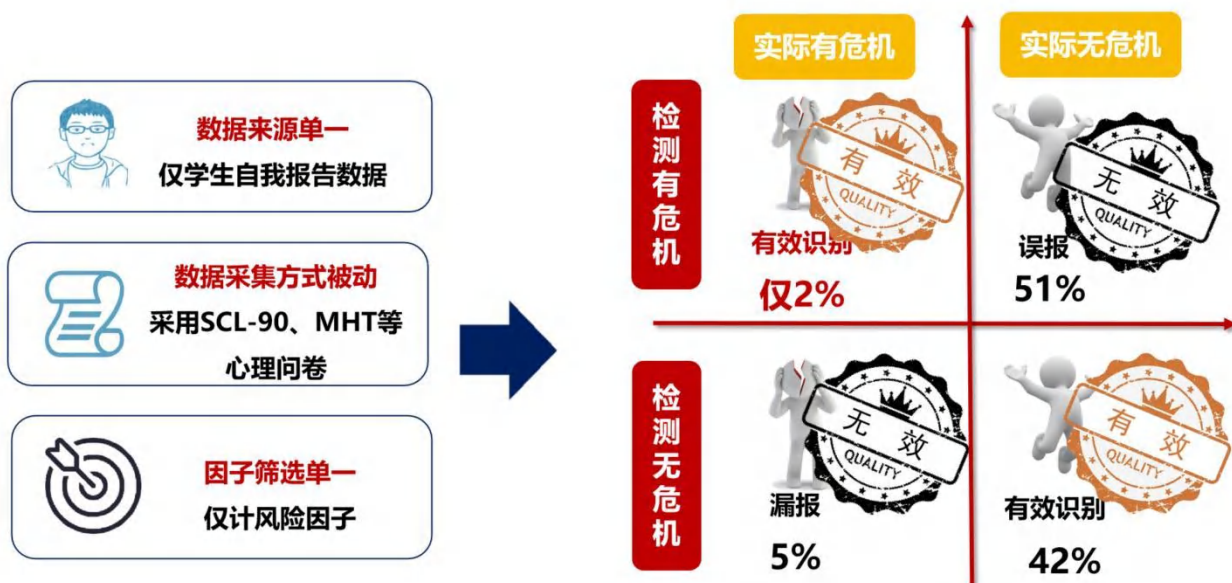
开展19次专家会谈
提出模型



覆盖4万余名学生
试点实践

社会痛点

现有心理危机被动识别，数据来源单一，“误报”“漏报”现象严重，



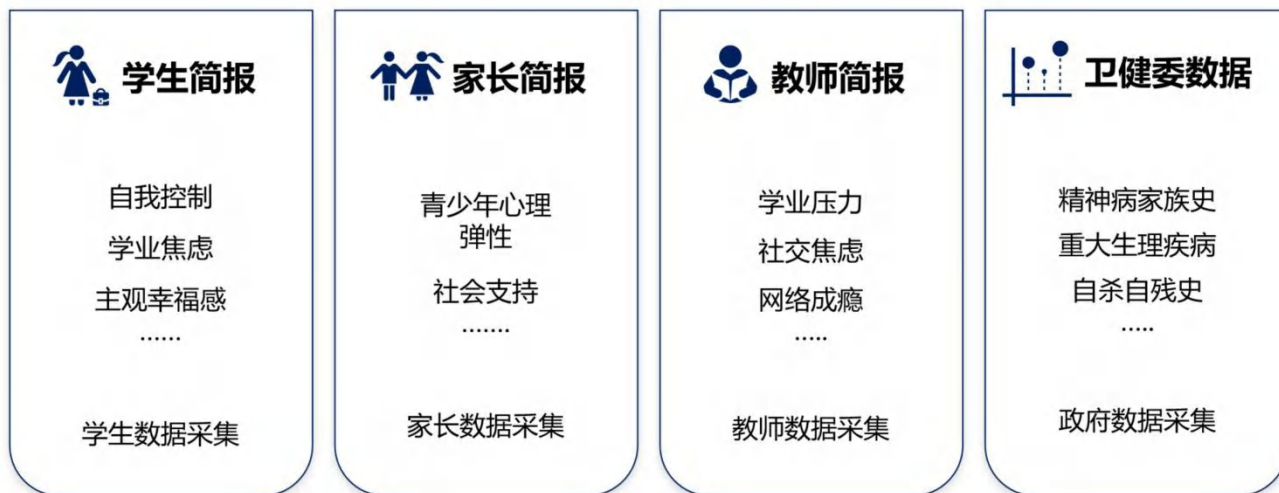
解决思路

系统增加心理数据来源，提高筛选精准度



数据获得

多方评估采集学生数据，提高测量精准性



数据流程



数据反馈

平台算法精准识别，智能赋码主动预警

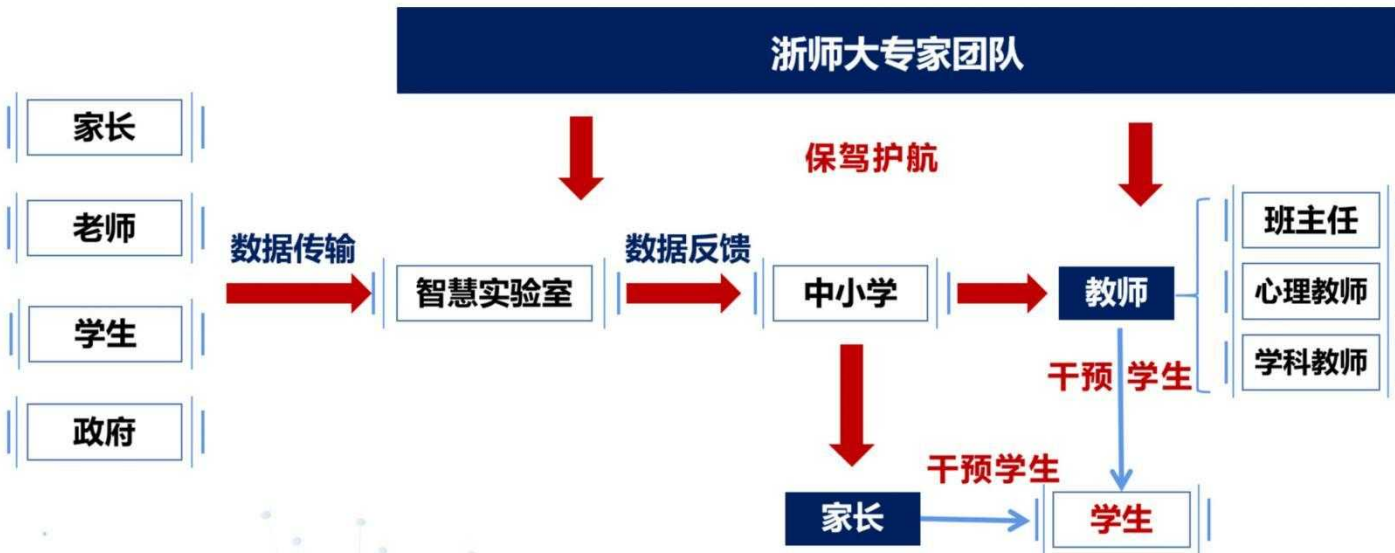


分级反馈图

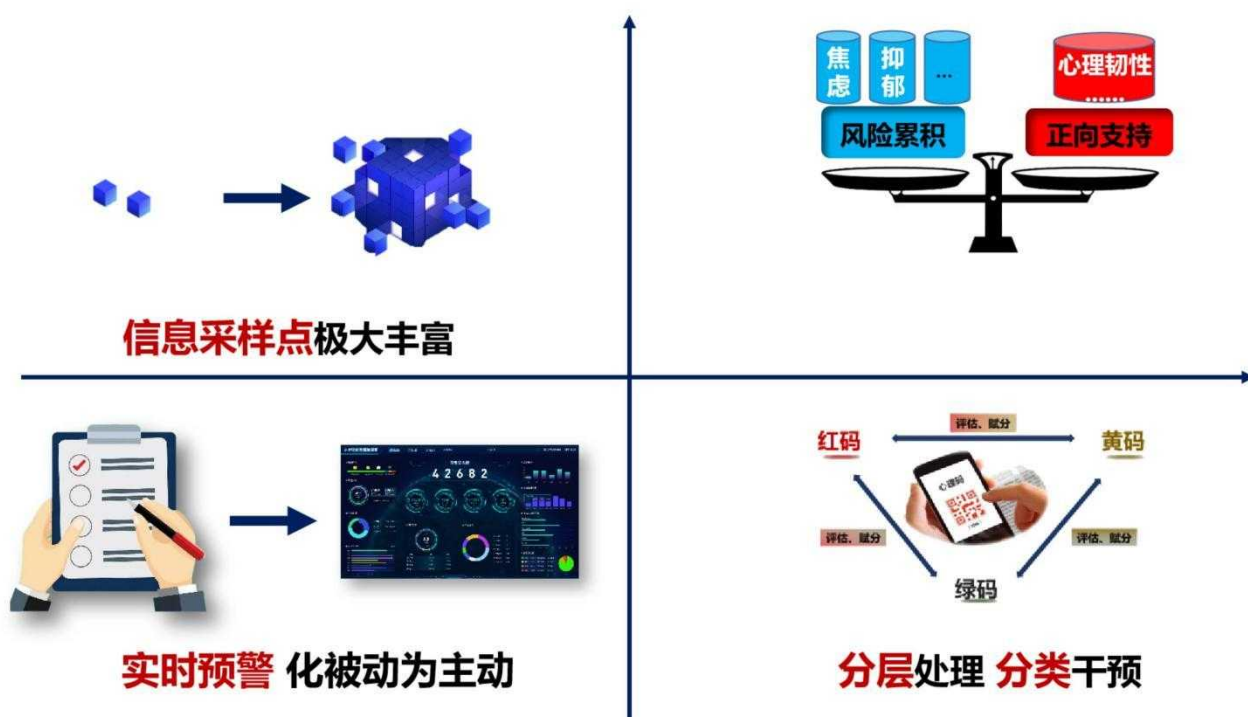
分类解决

学生分级	分类赋码	分类服务
2%	高风险人群	生命教育 压力疏导 心理咨询 家长工作坊
2-5%	(红码黄码)	生命教育 心理咨询 团体辅导 家长工作坊
5-20%	中风险人群 (橙码)	压力辅导 团体辅导 家长工作坊
20-100%	低风险人群 (绿码)	积极品质教育 心理运动会 心理文化节

标准操作流程



项目创新



项目历程

以点带面 辐射全省

- 2021年6月 ● 深入全省各区县开展调研
- 2022年3月 ● 以龙游县为试点
- 2022年3月 ● 走心驿站成功上线浙里办
- 2023年 ● 在浦江、乐清、桐乡展开推广
- 2023年3月 ● 开展首届心理健康教育数字化改革高峰论坛
- 未来 ● 全省推广，迈向全国



案例成果

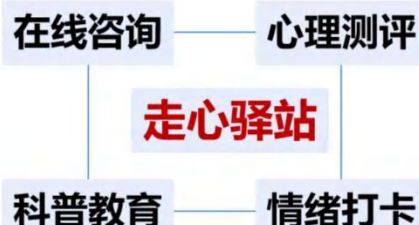
浙江省衢州市龙游县“走心驿站”上线以来，成绩斐然

已成功上线 “浙里办”平台

- ✓ 注册用户**12万**余人
- ✓ 日均访问量达**5.6万**次
- ✓ 系列视频点击量高达**230万**次
- ✓ 覆盖该县**43所**中小学，参与家长**8.6万**余人



“浙里办”平台 走心驿站模块界面



为龙游培养一支心理教师骨干团队，带动当地心理健康教育发展

✓ 班主任教师

初级学生问题**发现**者
中级学生问题**解决**者
高级学生问题**指导**者

心理教师骨干团队



✓ 学科教师

初级心育**参与**者
中级心育**引导**者
高级心育**发起**者

✓ 心理专职教师

初级心理**辅导**专家
中级心理**服务**专家
高级心理**督导**专家

✓ 管理参与者

校长
家长代表
社区干部

项目推广

通过示范试点、自有渠道等多重手段，持续推广“走心驿站”方案

走心驿站 → 拓宽自有渠道



- 1.加强政府合作：依托教育局等部门在客户群体形成良好口碑
- 2.权威单位推荐：依托浙江省心理学会、浙江省中小学心理健康教育指导中心等机构，提供技术认可和推广
- 3.导师人脉：依托导师人脉拓展业务
- 4.树立样本效应：依托龙游等样板基地打响“走心驿站”品牌

未来规划

“走心驿站”迭代工程



- 关键技术、核心指标算法完善行动
- “走心驿站”应用升级行动

“走心驿站”未来推广



- 召开高峰论坛等促进全省心理健康教育数字化改革
- 和浙江省中小学心理健康教育指导中心达成合作，联合实施省级层面心理健康改革行动

“走心驿站”资源整合



- 教师数字化心理健康服务素养全员轮训行动
- 高校人才心理健康教育会议论坛

2023年3月24日在衢州市龙游县召开浙江省首届中小学心理健康服务数字化改革高峰论坛



探索山区内生动力助推教育共同富裕示范区建设新路径

专家推荐

李
伟
健



中国心理学会常务理事
浙江师范大学教授

“走心驿站”是数字技术与心理健康教育的深度融合，加快“走心驿站”青少年心理健康服务数字化建设，培养学生积极乐观、健康向上的心理品质，促进学生全面健康成长。

周
晓
林



华东师范大学
心理与认知科学学院
名誉院长

“走心驿站”结合数字赋能与心理赋能，将心理学应用于实际，推广至全省，带动全省心理健康顶层体制建构科学化、底层服务方式专业化。

庞
红
卫



浙江省中小学
心理健康教育指导中心
办公室主任

“走心驿站”是一个打破壁垒的多元交互式心理服务平台，多角度、全方位为龙游县的中小學生提供及时有效的心理咨询服务，推动了龙游县心理健康教育的发展，也为其他地区提供借鉴意义。

乐
国
安



教育部高等学校心理学
教学指导委员会委员
国务院特殊津贴专家

“走心驿站”做到了心理健康服务的数字化与智能化，不仅重视风险因子，更从正向赋能的角度关注学生的积极心理素质，打造全方位、多角度的智能化服务体系，做到预防全、识别准、干预早。

摘要

全面提升青少年心理健康教育服务质量已经成为国家教育发展的重要一环。“二十大”强调要重视心理健康和精神卫生，加强建设心理健康工作和危机干预体系。《2022 年国民健康洞察报告显示》每 100 名学生中，就有 14 名遭受着心理健康困扰。心理健康教育数字化是实现心理赋能与数字赋能双重赋能的必由之路。但当前中小学心理健康教育仍存在大数据运用和服务效率低、力量资源不整合等问题。

本研究对浙江省 11 个地级市，90 个区县 37000 余人进行问卷调研，对 126 起自杀案例进行深入访谈，并开展专家研讨。总结归纳出当前浙江省中小学心理健康教育存在以上问题的原因：一是仅仅采用风险因子来识别学生心理健康状态；二是仅针对存在心理问题的学生进行干预咨询忽略心理服务的积极发展作用；三是仅依靠学校等教育相关部门进行心理健康教育无法整合社会各方资源。通过与专家老师的多轮研讨，在实践中不断探索，决定要走心理健康教育数字化改革的道路，通过数字赋能撬动心理赋能，最终实现心理服务从矫正心理走向积极发展的服务改革。

心理健康教育数字化是实现心理赋能与数字赋能双重赋能的必由之路。综合考虑技术、服务措施以及顶层设计，开发数字化心理健康服务体系新模式，做到心理健康教育即时性、精准性、高效性的有机统一。不仅消除学生的心理问题，还培养其积极品质，帮助开发其潜能。在技术上，通过大数据、机器学习等方式，将来自风险因子、保护因子以及诱发因子这不同维度、不同来源、不同模态的数据整合在一起。实现对学生心理健康精准画像与动态发展轨迹，真正做到学生心理危机的精准识别。在服务措施上，通过建立智慧实验室的方式，对不同学生将心理服务任务及时有效的分配给对应服务人员，实现全面连接互通、即时交互。此外，依靠机器模拟、人工智能能够给老师、家长、领导提供针对性切实有效的心理服务指导，最终实现智能干预。在顶层设计上，夯实县域心理健康服务顶层设计，建立健全区县市委教育工作领导小组直接领导的中小学心理健康教育工作联席会议，形成各部门资源整合畅通机制。合理配置公共资源，协调加强未成年人心理健康教育促进平安健康成长工作。

截止目前，我们在国内首创“风险累积-正向支持”心理危机干预辩证模型，精准识别省内 40 余万中小学学生，为全省 700 万中小学生心理危机精准识别与智能干预奠定基础；通过数字化、人工智能，对不同学生实行分级高效的干预，保障心理健康和生命安全的基础上，提升他们的综合素质；开设各级服务人员分层培训体系，打造一支具有积极心理学理念的全员化心理服务队伍，实现人人参与服务的心理服务格局；在国内首次实现“数字赋能撬动心理赋能”的心理服务改革，将理论转为实践应用，实现从学校教育模式走向社会心理服务体系；首次以 26 区县的率先改革推动全省心理健康教育服务领域，助力共同富裕。

关键词：心理健康教育服务、数字化、中小学、心理赋能、数字赋能

目 录

一、绪论	1
(一) 研究背景和意义	1
1.研究背景	1
2.研究意义	2
(二) 研究目的和内容	3
1.研究目的	3
2.研究内容	4
(三) 研究理论基础	5
1.系统观理论	5
2.协同理论	6
3.认知发展理论	6
二、浙江省心理健康服务状况调查	8
(一) 调研方法	8
1.问卷调查法	8
2.实地考察法	8
3.人物访谈法	9
(二) 调研过程	9
1.调研地点选取	9
2.问卷样本选取	9
3.访谈调研过程	10
4.实际调研足迹	11
(三) 调研结果	15
1.基本信息	15
2.现状分析	20
三、浙江省心理健康教育服务现存问题及原因	22
(一) 现存问题	22
1.心理危机筛查评估精准度低	22
2.心理危机干预及时有效性弱	22
3.心理健康服务体系整合性差	23
(二) 原因分析	24
1.政策落实不够到位	24
2.心理健康意识片面	25
3.教师待遇保障缺乏	26
4. 筛查干预方法落后	26
四、数字化心理健康服务体系新模式	28
(一) 大数据提升筛查评估精准度	28
(二) 人工智能增强干预服务有效性	30
(三) 流程再造统筹服务部门整合力	31
五、应用成效	33
(一) 风险累积-正向支持心理危机干预辩证模型服务中小学心理危机精准识别与智能干预	33

目录

(二) 心理服务能力图谱分级分类全员培训师资队伍	34
(三) 家长成长工作坊提升家长心育水平	35
六、未来展望	37
(一) 浙江省心理健康教育服务新模式推动全国心理健康教育服务改革	37
(二) 山区 26 县反哺推动全省心理健康教育服务领域实现共建共享和共同富裕	38
参考文献	39
附录	39
一、所获荣誉及成果展示	39
二、学校心理健康教育服务现状调查问卷	59
三、学校心理健康教育服务现状访谈提纲	65
(一) 教育部门访谈提纲	65
(二) 学校管理者访谈提纲	66
(三) 家长访谈提纲	69
四、项目合同	70
衢州市龙游县项目合同	70
五、专家推荐	78
(一) 华东师范大学周晓林教授推荐信	78
(二) 南开大学乐国安教授推荐信	79
六、查重报告	80

数“智”赋能下的心理健康教育服务新模式

——基于浙江百县千校的调研

一、绪论

（一）研究背景和意义

1. 研究背景

进入新时代,全面提升青少年心理健康教育质量已经成为国家教育发展的重要一环。“二十大”报告特别强调要“重视心理健康和精神卫生”和加强建设心理健康工作和危机干预体系。浙江省近两年也积极响应国家《“健康中国 2030”规划纲要》,重视心理健康尤其是中小学生的干预管理,2021 年发布《浙江省卫生健康委等关于加强心理健康服务的指导意见》,该文件要求加强儿童青少年心理健康教育,完善心理健康危机干预系统。这些政策不断推进心理健康工作的进步。近些年来,我国中小学健康事业发展迅速,学生身体素质显著提升。然而值得注意的是,学生的心理健康发展水平明显低于身体发展速度,身心发展不均衡的现象极为突出。在浙江省学校心理健康教育领域,师资队伍匮乏、基础设施落后,思想理念陈旧等问题普遍存在。尤其在龙游等 26 个加快发展县,县域经济在实现跨越式高质量发展的过程中广大人民群众对学校高质量心理健康教育的呼声尤为强烈,群众需求与县域心理健康教育实际发展之间的巨大鸿沟阻碍了社会和谐发展与美好生活创造。

为实现共同富裕,浙江省在全国率先部署了关系全局、影响深远、制胜未来的重大集成改革——数字化改革。心理健康教育数字化作为浙江省教育领域数字化改革中的排头兵攻坚队,是《浙江省教育领域数字化改革工作方案》的贯彻落实与引领示范。不断统筹推进数字技术与心理健康教育深度融合,以数字赋能为主线,推动心理健康教育体系数字化发展是实现省域教育共同富裕的必由之路。充分发挥山区 26 县在心理健康教育改革中的先发优势,借助数字化改革这一杠

一、绪论

杆，实现心理健康领域在全省乃至全国的弯道超车，为省域共同富裕战略贡献山区力量。

本研究响应国家共同富裕号召，顺应省域数字赋能主线，以系统思维提出“风险累积——正向支持”心理危机干预辩证模型，统筹区县心理健康教育资源与师资队伍。运用大数据建模、算法智能迭代、干预自动匹配等数字化技术在龙游县构建了“精准识别—智能干预—分层培训”体系和“人人善于心理服务、人人接受心理服务”的心理服务新局面，为全省心理健康教育的数字化改革与发展起到引领示范作用。

2.研究意义

当前，随着国家经济的快速发展，国民生活条件日渐改善的同时，国民心理健康发展状况近些年来也越来越多地得到国家和社会的重视。其中，儿童青少年作为祖国的花朵，应当实现德智体美的全面发展，才能勇担国家富强，民族振兴的伟大历史使命。就新时代浙江省积极推动数字化改革背景下中小学生学习心理健康发展现状，本研究将从研究选题、研究对象和学术层面进行探讨。

从研究选题角度看，心理健康问题近些年来出现低龄化态势，中小学习自杀自残事件屡见不鲜，了解中小学心理健康教育发展现状，弥补不足之处，对于未来建成和谐社会具有重要探索意义。本研究将在拓展已有未成年人心理健康教育发展研究的基础上，通过访谈和问卷调查，为改善中小学生学习心理健康发展现状提供新思路。

从研究对象角度看，如何使中小学生学习心理健康成长，实现全面发展是全面建成和谐社会的前提条件。本研究从全面建成和谐社会视角出发，综合浙江省37717位中小学生学习心理健康教育相关人员的问卷调查与1085份访谈录，聚焦中小学生学习心理健康教育现状，一方面更好的帮助广大中小学生学习心理健康成长，另一方面，以心理健康教育发展实践调研来检视现有中小学生学习心理健康教育服务模式下存在的不足之处，促进中小学生学习全面发展，推动社会和谐发展。

从学术层面看，中小学习心理健康体系的完善是对现有教育机制的一次“扬弃”，也是学术学业成绩提升和青少年健康成长之间冲突的集中和解。本研究以系统观理论为核心、协同理论和最近发展区理论为依托，从家庭、学校和社会三方面探

一、绪论

索儿童青少年心理健康服务新模式建立路径,既有利于儿童青少年心理健康成长,也为新时代现有教育体制进一步完善提供实践参考,为全面建成和谐社会注入新生力量,为缓解教育冲突问题提供借鉴参考。

(二) 研究目的和内容

1. 研究目的

心理健康教育数字化是实现心理赋能与数字赋能双重赋能的必由之路。通过大数据与人工智能等主要技术手段,实现学生心理状态的精准识别、智能干预、各种力量整合以及服务人员的科学培训,做到心理健康教育即时性、精准性、高效性的有机统一,不仅消除学生的心理问题,还可以开发其潜能。

通过大数据提升筛查评估精准度。从诱发、风险、保护三个因子的数十个维度对学生状态进行评估。根据深度图注意力网络算法,采用数学建模的方式整合不同维度、不同来源、不同模态的数据,建立多模态数据支持下的未成年人心理健康水平核心算法。结合大数据分析,锚定整个区县危机学生比例,实现学生心理健康精准画像与动态发展轨迹可视化。

借助人工智能增强干预服务有效性。通过人工智能、大数据、数字化等技术手段在龙游县建立智慧实验室。这样不仅能够将整个区县的学生数据进行汇聚整合分析,更能够实时监控学生心理情绪变化,针对不同学生将心理服务任务及时有效的分配给对应服务人员,实现全面连接互通、即时交互。此外,依靠机器模拟、人工智能能够给老师、家长、领导提供针对性切实有效的心理服务指导,最终实现智能干预。

实行流程再造统筹服务部门整合力。通过数字化流程实现对学生心理服务智能分解目标与精准派遣任务。以心理健康教育工作小组的形式使各部门各司其职相辅相成,保障高效的心理服务。对各服务人员进行分层培训,实行专人专项工作,在保证生命安全、心理健康的基础上,帮助学生开发潜能,提高综合素质。

2.研究内容

为实现中小学心理健康教育数字化改革，本项目组通过“文献查阅—实地调研—问题总结—对策提出—实践验证”的思路对来开展本研究。

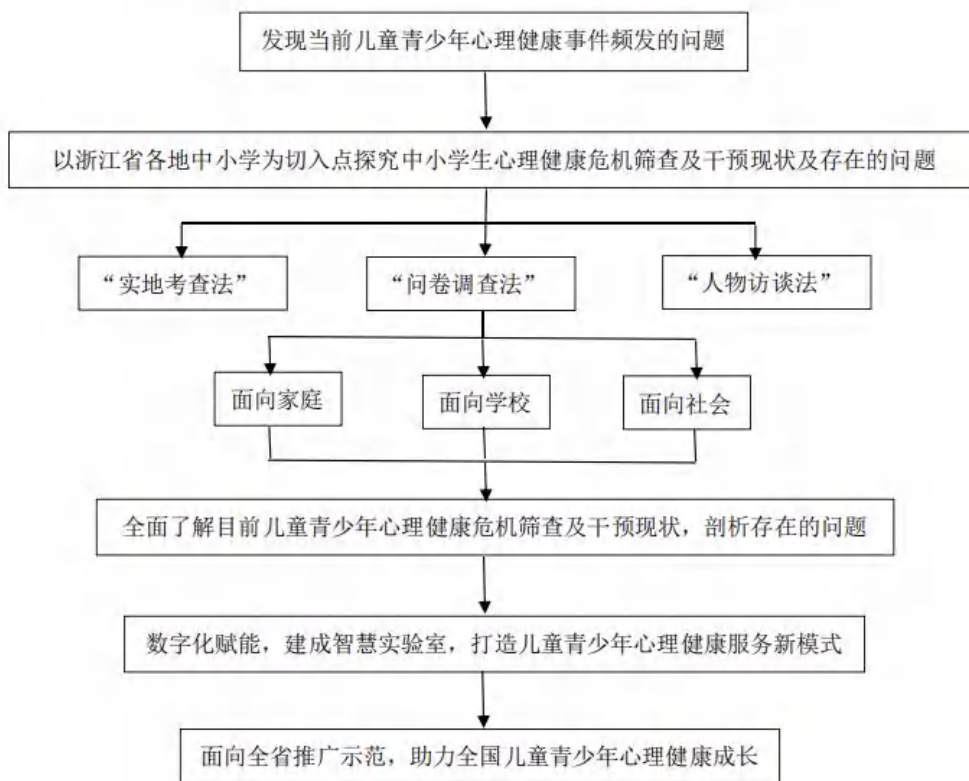


图 1-1 研究过程图

首先，本研究通过文献阅读对当前中小学心理健康教育的发展及现状做一个全面的了解，总结他人在该领域的优秀做法以及不足之处。

其次，我们通过实地调研，深入中小学第一线课堂。通过对浙江省三万七千余人进行问卷调查，并对学生、家长、教师、政府工作人员等不同群体进行深入访谈，以掌握目前中小学心理健康教育中现状及不足之处。发现当前中小学心理健康教育存在着心理健康教育意识不够科学全面、学生心理健康筛查评估精准度有待提升、学生缺乏个性化心理服务、心理健康教育主体单一，力量不整合等问题。

再次，针对总结凝练的问题，本研究以系统观、协同理论、最近发展区等为理论基础，从心理健康服务理念、心理危机筛查和干预、心理服务力量等角度出发去解决问题。通过有教育部门牵头领导形成心理健康教育工作领导小组的形式让社会各方的力量参与到中小学心理健康服务当中，打造“人人接受心理服

一、绪论

务，人人参与心理服务”的系统观念。借助大数据、数字建模的方式，以系统思维提出了“风险累积—正向支持”心理危机干预辩证模型，保障学生心理危机的精准评估。依托人工智能、大数据、数字化等技术手段，建立智慧实验室，实现对不同学生的智能干预。

最后，本项目的实践成果已经在衢州市、浙江省、教育部作为优秀典型案例示范推广。通过这样的影响力，走出浙江省、面向全国，为全国中小学心理健康教育服务模式的改革出一份力。

（三）研究理论基础

1. 系统观理论

系统观认为，社会生活中的事物都是一系列密切联系、协同作用的要素所构成的、具有一定结构和功能的系统（贾支正，张钰，2022）。系统之间的要素相互依赖且相互影响（聂妮，2022）。系统观强调要充分考虑要素与要素、要素与系统、系统与外部环境间的关系和相互作用（Bronfenbrenner, 1979）。

心理健康教育服务体系是一个庞大的系统，由青少年心理健康系统、心理危机识别系统、心理危机干预系统、和心理服务保障系统组成（McLennan et al., 2023; Xiu, 2011）。青少年心理健康状态是一个复杂的系统，由多种因素如生理、心理状态性、环境等相互作用共同决定（姚远，程诚, 2021; El-Hage et al., 2019; kidd et al., 2006）。心理危机识别系统在充分考虑青少年心理健康状态复杂性的基础上，由风险因子、诱发因子和保护因子以及三种因子下设的多种因素构成（彭帆，韩立敏, 2023）。心理危机干预系统由干预主体、干预对象、干预活动构成，在对青少年的心理健康状况进行干预时，要将干预主体与干预对象对应，针对性的运用不同干预方式确保干预的有效性（孙晓红，韩布新, 2018）。青少年心理健康状态作为一个子系统存在于心理危机识别和干预系统中，各子系统之间、子系统与心理服务总系统、以及心理服务总系统与外部环境之间的相互作用，从而更为全面、准确地检测学生的心理危机状况，确保心理危机精准识别和干预以及心理服务的有效实施，确保心理健康服务体系高效运转（王歆睿，韩布新, 2023）。

2.协同理论

协同理论由德国理论物理学家 Haken 教授(1969)提出,该理论认为尽管各个子系统属性不同,但系统之间是相互影响、相互合作的关系。在一个大的复杂系统中各子系统有序组织、有效配合、共同作用使系统整体功能提升大于各子系统功能提升总和,达到“ $1+1>2$ ”的效果(冒巍巍, 2021; Pickering et al., 2004; Reist, 2022)。该理论为本模式中心理服务保障机制的组织机构、部门协同以及制度保障提供了强大的理论支撑(Peters, 2002)。中小學生心理健康服务体系建设作为一项系统工程,存在复杂的特征维度和层级面向,而协同自身所具有的开放性、目的性、整体性及不平衡性非常适应数字化心理健康服务体系中各系统的排列组合,在复杂的多元素中获取所需资源并优化排列整合(王志伟, 2022; Renu, 2018)。

基于协同理论综合考虑心理服务后背保障机制,各组织机构部门协同,国家政策、制度保障、经费保障、监督考核作为整个保障机制,有利于进一步优化和完善心理健康服务体系(张鸣哲等, 2019)。心理健康教育服务体系除了心理服务后背保障机制,核心力量包含家庭、学校、社区、医院等各方面,家、校、社、医院在各自发挥作用的同时相互合作发挥协同力量(Rugkåsa, 2020; Sundet, 2020)。为确保各方力量的有效发挥并协同,采取对各方针对性的进行不同的培训和指导的方式(窦媛, 乔东平, 2023)。注重心理健康教育师资队伍的培养和扩建包括对学校的分管校长、专任老师、学科老师、班主任的培训,其次是社区的社区干部、社区医院和学生家长,由培养的师资力量进一步开展社区辅导和家长工作坊。此外,学校师资力量与家长和社区医院应做好配合工作,出现心理危机严重的同学要及时转介并去医院就诊,学校随时跟进学生的心理健康状况。目前培训计划的实施历时三年,每年完成一个阶段性培训任务。使各方在心理健康服务系统下发挥力量的同时,进一步相互作用发挥更深层次的作用。

3.认知发展理论

心理学家维果茨基提出认知发展理论(Vygotsky, 1977),其中“最近发展区”观(Shokouhi et al., 2015; Van et al., 1989)认为学生有目前存在的发展水平,以及潜在的即可以在他人的帮助下达到的发展水平。基于最近发展区理论,学生的

一、绪论

心理危机程度是不同的（Campione et al., 1984; Xi, 2021; Rogoff, 1999），根据学生的心理危机程度进行分层干预，将学生在各个心理危机测评得到的数据，按照心理危机的严重程度赋予不同颜色的码，对心理健康状况良好的学生群体赋绿码，中度心理危机人群赋黄码或橙码，重度心理危机人群赋红码。根据码颜色的不同配备干预辅导人员和适合的干预方式。对赋绿码的学生进行普适性心理服务，主要是通过心理运动会和心理文化节促进青少年保持积极的品质。对赋橙码的学生则施加额外心理服务，通过团体辅导和家长工作坊对学生进行压力疏导。对被赋红码或黄码的学生进行专门性的心理服务，在前者的基础上对学生进行心理咨询。分层干预辅导为心理危机程度不同的学生提供合适的心理服务方式。为心理危机程度严重的学生提供较多的心理干预，帮助他们更快地恢复心理健康（赵献梓, 王剑彪, 2021; Hasse, 2001）。



二、浙江省心理健康服务状况调查

本项目通过查阅有关文献，了解心理健康教育发展历程，寻找研究工具，为模型构建提供理论依据。本研究在确定研究问题的基础上通过文献法收集资料，主要通过计算机检索，把握浙江省县区学校数字技术与心理健康教育结合发展现状，产生这一现状的原因以及改善提升的策略，为后续分析在因素探究与策略实施过程中可能会面临的困境，归纳探求出一套有效的心理危机干预辩证模型和数字化心理健康服务体系。

（一）调研方法

1.问卷调查法

发放问卷对 90 县区进行调研，搜集数据完成分析，探究现存的教育体系中存在的不足之处。团队采用问卷调查法开展研究，该方法能调查结果进行量化，便于统计处理和分析。问卷从学生、教师和家长等方面综合考虑学生的心理健康情况，了解家庭、学校和社区对学生心理健康重要性的了解程度，找出不足之处并为后续研究的开展奠定基础。

2.实地考察法

对有关县区进行实地走访，了解当地教育发展状况及当地心理健康教育服务水平。实地考察法是为明白一个事物的真相，事态发展流程，去实地进行直观的，局部进行详细的调查。本团队为深入剖析浙江省山区 26 县学校学生心理健康教育存在的难题，先后实地走访了浙江省 26 县区的小学，了解各个学校心理健康教育发展状况，例如学校心理测评体系准确性难题、心理健康专职教师团队建设难题、心理健康教育基础设施建设难题、心理健康教育质量保障难题等，为后续改进心理健康服务体系指明了方向。

3.人物访谈法

对学校，社区，政府等多部门有关职能人员进行访谈，从多个角度对当地心理健康服务体系进行分析，确定完善方案。访谈带有一定的计划性和目的性，通过与被访谈者的深层次交流，以获取第一手资料，从而更好地了解被访谈者的真实看法和意见。本团队通过浙江省 26 区县学校，社区，政府等多部门有关职能人员进行访谈，了解他们对于中小学心理健康教育的认识情况以及各自开展心理健康教育工作时存在的难点等。根据访谈结果，从多个角度对当地心理健康服务体系进行分析，确定完善方案。

(二) 调研过程

1.调研地点选取

调研地点选取于浙江省 11 个地级市，90 区县下中小学以及当地教育管理部门，其中主要调研地点为衢州市龙游县、嘉兴市桐乡市、金华市浦江县和温州市乐清市。

2.问卷样本选取

(1) 问卷内容设计

结合调查主题、内容、目的及意义，团队成员通过查阅大量相关文献学习已有调查问卷编写经验，通过网络，新闻媒体以及在日常生活中搜集信息，主要针对浙江省中小学心理健康教育发展现状及其存在的不足之处等方面来设计问卷初稿。

(2) 问卷预调查

考虑浙江省心理健康教育区域发展现状选取以龙游为代表的山区 26 县进行预调研，随机抽取 10 所学校，共选取学校所在地学生、家长、教师等心理健康工作相关人员 1000 名发放问卷调查，其中回收有效问卷 914 份。发现问卷中存在的问题以及调查过程中可能存在的问题。

(3) 问卷修改

根据预调查出现的问题，问卷填写者对问卷的设计、维度、以及措辞提出的意见和建议，组织小组讨论，并与指导老师交流意见后对问卷进行修改。

(4) 确定终稿

采用信度分析和效度分析对修改后的问卷质量进行评估分析，最终设计出一份既符合项目要求又便于统计分析的调查问卷。

3. 访谈调研过程

(1) 访谈前期准备

综合浙江省心理健康教育工作发展现状，确定浙江省各县市的教师，家长，学生包括学校与学校所在地政府中的心理健康教育相关行政人员作为访谈对象。其中对学生心理健康发展关系最为密切的教师，家长及学生进行重点访谈。通过浙江省教育厅心理健康教育及数字化改革相关文件，当地政府网站与新闻媒体报道搜集数字赋能助力心理健康教育发展的工作概况，形成对当地学校心理健康教育发展情况的初步了解。

(2) 访谈对象确定

本次调研的访谈对象主要由家庭、学校及社会三大主体构成。家庭包括学生实际监护人，即学生家长；学校包括学生、学科教师、班主任、心理健康专职老师及学校相关行政人员；社会包括教育局等政府部门相关工作人员。计划每个学校选择 3 名班主任老师、1 名心理健康专职老师、3 名学科教师、1 名学校行政人员、1 名政府教育工作人员、3 名学生和 3 名家长进行访谈调研，共计 1085 人次。

(3) 访谈提纲设计

以数字赋能助力中小学心理健康教育发展情况为访谈设计思路，就当地数字赋能相关措施，以心理健康教育发展成效作为衡量指标，与其他部门协调情况为内容设计访谈问题。实验模拟访谈过程，就实验过程出现的问题根据实验双方的建议，组织小组讨论，并与指导老师交流后修改。

二、浙江省心理健康服务状况调查

(4) 访谈过程安排

在访谈前，事前联系当地学校干部和公职人员，全方位做好准备，有针对性、突出性地进行访谈；在访谈中，征得同意后做好录音、录像和笔录工作；在访谈后，做好整理，将访谈日记与资料查找相印证，增强数据和信息的可靠性。

表 1 项目调研程序表

调查程序	工作内容	时间
一、准备阶段	小组讨论、确定调研主题	2021 年 7 月 16 日
	方案撰写、问卷与访谈设计	2021 年 7 月 23 日—— 2021 年 8 月 2 日
二、实施阶段	向衢州市龙游县发放预调查问卷	2021 年 8 月 10 日—— 2021 年 8 月 18 日
	中小学小组成员访谈、专家访谈	2021 年 10 月 8 日—— 2022 年 1 月 5 日
	正式向浙江省 90 区县发放问卷	2022 年 3 月 4 日—— 2022 年 6 月 15 日
三、研究阶段	信息数据整理、汇总	2022 年 9 月 3 日—— 2022 年 10 月 12 日
	信息归纳、分析	2022 年 10 月 20 日—— 2022 年 11 月 28 日
四、分析阶段	调研报告撰写与评估	2022 年 12 月 5 日—— 2023 年 1 月 10 日

4. 实际调研足迹

本团队为深入剖析浙江省山区 26 县学校学生心理健康教育存在的难题，先后实地走访了浙江省 26 县区的小学，了解各个学校心理健康教育服务状况。其中，本团队重点走访了龙游县、桐乡市、安吉县及浦江县，在当地开展心理健康服务改革并取得一定成效。（下图为部分调研材料汇总）

二、浙江省心理健康服务状况调查

表 2 项目重点调研县（市）及成效

调研县（市）	取得成效	
龙游县	建设“走心驿站”儿童青少年心理健康服务数字化平台	在首届中小学心理健康教育数字化改革高峰论坛中这四个县（市）就本区域心理健康教育服务数字化改革分享经验
桐乡市	举办“阳光桐心”儿童青少年心理健康服务全民性活动	
乐清市	开展“关爱帮扶一件事”儿童青少年心理健康护航行动	
浦江县	设立“心路e通”儿童青少年心理危机防护管理体系	
.....		

四、龙游县调研足迹



二、浙江省心理健康服务状况调查

(P) 桐乡市调研足迹



二、浙江省心理健康服务状况调查

(3) 乐清市调研足迹



(4) 浦江县调研足迹





(三) 调研结果

1. 基本信息

(1) 样本结构分布

本次调研共发放问卷 37717 份。其中问卷填写者的性别、年龄和身份均分布于各个层次，符合实际状况，具体如图所示。

调研结果显示，参与调研的女性群体居多，占比为 68.51%，男性群体占比为 31.49%。性别占比不均匀的原因在于心理健康教育服务工作者群体中，女性的数量远超男性数量。



图 2-1 性别统计结果

从年龄统计结果来看，调研群体中大多数为 31-40 岁的工作者，占比为 49.19%，其次为 41-50 岁群体，占比为 24.66%，20-30 岁和 50 岁以上的调研对

二、浙江省心理健康服务状况调查

象占比最少，为 5.97%、5.19%。

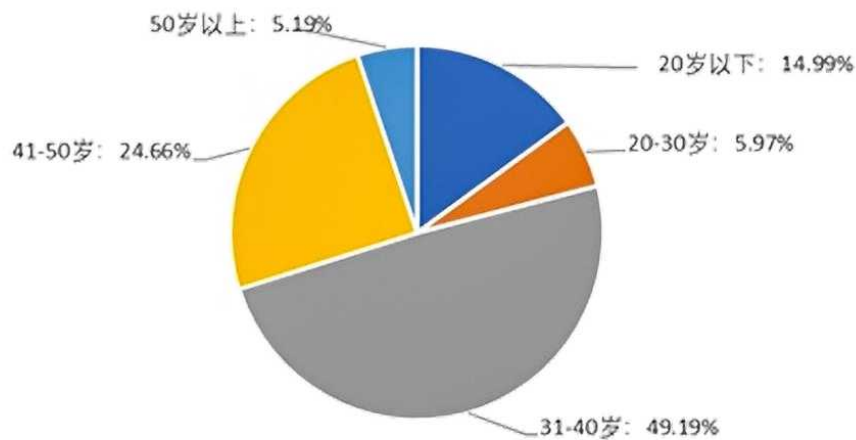


图 2-2 年龄统计结果

调研群体分布涵盖教育部门工作人员、非教育部门工作人员、学校管理者：校长、班主任、心理健康专职教师、及学生和学生家长。其中，学生家长占比最大，为 76.78%，其次为学生群体占比为 16.18%，非教育部门工作人员占比为 7.54%，学校管理者中班主任占比为 4.63%、心理专职老师和校长占比最少为 1.44%、0.59%。

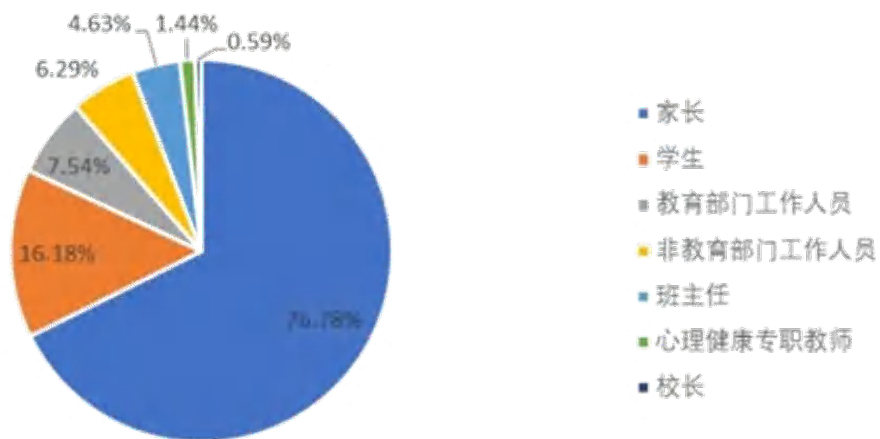


图 2-3 职业统计结果

(P) 信效度分析

信度（Reliability）即可靠性，它是指采用同样的办法对同一对象重复测量时所得结果的一致性程度。多以相关系数表示。从下表可知：信度系数值为 0.831，大于 0.8，因

二、浙江省心理健康服务状况调查

此说明研究数据信度质量较好。针对“项已删除的 α 系数,”任意题项被删除后, 信度系数并不会会有明显的上升, 因此说明题项不应该被删除处理, 现对问卷题目进行分析。

表 3 问卷各项目 Cronbach 信度分析表

名称	校正项总计相关性 (CITC)	项已删除的 α 系数	Cronbach α 系数
您认为心理健康教育对于学生来说重要吗	0.053	0.832	0.831
您认为心理健康教育服务的对象是	0.150	0.831	
您认为心理健康工作会影响学生的学习成绩吗	0.153	0.832	
您认为现在的学生会主动寻求心理老师的帮助吗	-0.036	0.838	
您认为学校现在的学生心理健康调查是否精准	0.066	0.838	
您认为当前测量学生的心理健康的问卷是否科学	-0.052	0.836	
您以往是否参加过专业的心理健康教育培训	-0.091	0.835	
您认为心理健康教育工作者的工作压力大么	0.111	0.838	
您认为现在心理健康教育工作者的待遇如何?	0.062	0.838	
您认为学校学生提供个性化服务吗	-0.035	0.840	
心理健康教育主要是学校的责任	0.070	0.835	
消除学生负面情绪	0.239	0.829	
提高学生学习成绩	0.365	0.827	
促进学生更好的成长发展	0.336	0.829	
担心被贴标签	0.191	0.830	
心理健康教育没用	0.262	0.829	
精准识别心理危机学生	0.449	0.825	
智能干预学生心理问题	0.357	0.827	
矫正部分人对心理健康的错误认识	0.357	0.827	
阅读相关书籍	0.286	0.829	
网络平台推送	0.342	0.827	
参与相关系列课程培训	0.348	0.827	
学校	0.273	0.829	
社区	0.307	0.826	
心理咨询机构	0.399	0.829	
利用大数据进行精准识别、智能干预	0.346	0.827	
对相关人员进行定期培训考核	0.393	0.827	
家校社联动	0.379	0.827	
缺乏心理健康教育意识	0.279	0.829	
缺乏心理健康教育技能	0.374	0.827	
没有时间精力参与	0.317	0.828	
会影响学生学习成绩	0.311	0.828	

表 4 问卷 Cronbach 信度分析-简化格式

项数	样本量	Cronbach α 系数
32	1000	0.831

二、浙江省心理健康服务状况调查

注：校正的项总计相关性：此指标通常用于判断题项是否应该做删除处理，如果值小于 0.3，通常应考虑将对应项进行删除处理；

项已删除的 α 值：此指标用于判断题项是否应该做删除处理，如果该值明显高于“ α 系数”值，应该考虑将对应项进行删除处理。

13) 频率分析

将经过整理的调查问卷所取得的数据由 SPSS 软件汇总处理后，对样本的特征进行统计，得到各个选项的频数和百分比，直观地反映各项数据水平。

表 5 心理健康教育对学生是否重要统计表

选项	频数	百分比	累积百分比
重要	37791	99.71%	99.71%
不重要	111	0.29%	100.00%
合计	37902	100.00%	

表 6 心理健康是否影响学生成绩的频数分析结果表

名称	选项	频数	百分比	累积百分比
5.您认为心理健康教育工作会影响学生的学习成绩吗	会，会占用学生的学习时间	3757	9.91%	9.91%
	不会	8654	22.83%	32.74%
	能够更好的促进学生的学习	25491	67.26%	100.00%
合计		37902	100.00%	

根据第三题和第五题的频率分析，大多数人认为心理健康教育对学生来说重要并且能够更好地促进学生的学习。由此可见，本项目数字赋能，心理赋能的实践思路能够得到教师的认可，具有足够的可行性和合理性。

表 7 学生自杀自残问题所在统计表

名称	选项	个案数	个案百分比
18.对于学生自杀自残，您认为问题是	心理测评无法精确识别心理危机学生	22529	58.73%
	对心理危机学生无法做到智能化干预	24054	64.46%
	对学生心理健康重视程度不够	28627	75.53%
	一些“成绩论”的观点导致越来越多的学生出现心理问题	29091	76.65%
合计		104301	275.17%

二、浙江省心理健康服务状况调查

根据第十八题的频率分析大多数人认为学生自杀自残的情况,和心理测评无法精确识别心理危机学生、对心理危机学生无法做到智能化干预、对学生心理健康重视程度不够以及一些“成绩论”的观点导致越来越多的学生出现心理问题这些问题有关。由此可见,我们的项目根据这些问题进行解决后会改善目前的心理健康发展状况,具有可行性。

表 8 推动学校心理健康教育途径统计表

名称	选项	个案数	个案百分比
23.您认为推动学校心理健康教育有哪些途径?	利用大数据进行精准识别、智能干预	26273	69.32%
	对相关人员进行定期培训考核	30491	80.45%
	家校社联动	30953	81.67%
	其他	742	1.96%
合计		88459	233.00%

由表可知,认为利用大数据进行精准识别、智能干预可以推进心理健康教育的有 26273 人次,认为通过对相关人员进行定期培训考核的有 30491 人次,认为可以通过家校社联动的有 30953 人次,认为还有其它方法途径的有 742 人次。从百分比看,大多数人认可通过家校社联动、相关人员定期培训、大数据精准识别干预推动心理健康教育途径,因此项目组提出的数字赋能、家校社联动的心理健康教育新模式的实践思路是具有可行性的。

表 9 影响老师参与心理健康教育工作主要原因统计表

名称	选项	个案数	个案百分比
24.您认为影响老师参与心理健康工作的主要原因是?	缺乏心理健康教育意识	26308	69.41%
	缺乏心理健康教育技能	29240	77.15%
	没有时间精力参与	24147	63.71%
	会影响学生学习成绩	9160	24.17%
合计		88855	234.00%

上文中表格数据显示大多数人认为家校社联动是推动学校心理健康教育的可行途径,但实践调查结果却与之相悖,大多数学校几乎未进行家校社联动。基于此,对家校社联动无法顺利推行的原因进行分析。

由表可知,认为受缺乏心理健康教育意识影响的有 26308 人次,认为受缺乏心理健康教育技能影响的有 29240 人次,认为没有时间精力参与的有 24147 人次,

二、浙江省心理健康服务状况调查

认为考虑到会影响学生学习成绩的有 9160 人次。从百分比看，大多数人认为影响老师参与心理健康教育工作的主要原因是缺乏心理健康教育意识和技能以及没有时间精力，因此项目组的数字赋能、培训相关人员心理健康教育新模式的实践思路是具有可行性的，可以在最大程度减轻教师时间精力负担的同时增加其心理健康教育意识和技能。

表 10 影响家长参与心理健康教育工作主要原因统计表

名称	选项	个案数	个案百分比
25.您认为影响家长参与心理健康工作的主要原因是？	缺乏心理健康教育意识	31484	83.07%
	缺乏心理健康教育技能	31386	82.81%
	没有时间精力参与	23282	61.43%
	会影响学生学习成绩	8546	22.55%
合计		94698	250.00%

由表可知，认为受缺乏心理健康教育意识影响的有 31484 人次，认为受缺乏心理健康教育技能影响的有 31386 人次，认为没有时间精力参与的有 23282 人次，认为考虑到会影响学生学习成绩的有 8546 人次。从百分比看，大多数人认为影响家长参与心理健康教育工作的主要原因是缺乏心理健康教育意识和技能以及没有时间精力，较少受到学生成绩影响。由此可见项目组依托线上平台、培训相关人员心理健康教育新模式的实践思路具有足够的可行性和合理性，可以在最大程度减轻家长时间精力负担的同时增加其心理健康教育意识和技能。

2.现状分析

1) 心理健康教育意识提高

近年来中小学学生心理危机事件频发，社会越来越重视学生心理健康问题。党中央、国务院高度重视心理健康服务和社会心理服务体系建设工作。将我国全民心理健康意识的提高和全民心理健康素养的普遍提升纳入基本目标，大力普及心理健康教育知识。此外，浙江省 2020 年发布的《浙江省关于加强心理健康服务的指导意见》政策指出，针对社会公众开展心理健康促进与教育，通过多种形式和平台，广泛开展心理健康科普宣传，采用群众喜闻乐见的形式将心理健康知识融入群众文化生活。要求专科医院、开设心理门诊的综合性医院及社会心理健

二、浙江省心理健康服务状况调查

康服务机构要规范开展心理咨询与心理治疗服务。短视频软件、公众号也大力宣传心理健康教育相关知识。

(2) 心理健康专业师资力量增强

全国人民代表大会常务委员会颁布了《中华人民共和国精神卫生法》，明确指出：“各级各类学校应当对学生进行精神卫生知识教育；配备或者聘请心理健康教育教师、辅导人员，并可以设立心理健康辅导室，对学生进行心理健康教育”。国家政策的引领下，当前我浙江省乃至全国都越来越重视心理健康人才队伍的建设，通过加强心理健康专业人才培养、促进心理健康服务人才有序发展、完善心理健康服务人才激励机制等方法，应用型心理健康专业人才培养力度大大得到了提升，心理健康专业师资队伍得到了完善，推动了中小学心理健康服务的规范化。

(3) 心理危机筛查干预机制提升

在 2021 年《教育部办公厅关于加强学生心理健康管理工作的通知》中指出，我们要积极借助专业工具和手段，加快研制更符合中国学生特点的心理测评量表，定期开展学生心理健康测评工作，健全筛查预警机制，及早实施精准干预。在全国数字化改革背景下，教育部门制定学校处置心理高危学生的流程及流转细节，向公安部门提供学生社交通讯信息，并开展全面心理健康普查和摸排，以便结合互联网及公安大数据建立学生网络异常行为、心理高危学生预警模型。通过各方配合，将心理健康教育与大数据进行结合，心理危机筛查准确性得以提高。

三、浙江省心理健康教育服务现存问题及原因

（一）现存问题

1.心理危机筛查评估精准度低

项目组在实地调研走访过程中了解到，心理健康服务在筛查评估方面主要存在以下问题：一是单一因子测量问卷不够科学。大部分中小学心理危机测评使用的问卷仅考虑风险因子，例如焦虑量表、抑郁量表等。但在学生心理发展过程中，既有压力、焦虑事件等风险因素，也有关怀、鼓励等支持因素。所以仅考虑风险因子的测量问卷缺乏科学性。二是国外引进问卷本土化程度低。大部分中小学普测使用的问卷是十几年前从国外引进的 SCL-90、MHT、SDS 等，但国内外的成长环境存在很大的差异，所以问卷的适宜性有待考量。国家也一再强调要研制更符合我国的心理测评问卷。三是学生自主填报问卷客观性低。大部分中小学对学生的心理健康程度评分仅依靠学生自主填写的测评表，这造成极大的主观性。学生可能无法精确理解问卷题目和选项的含义，可能在填写过程中会故意隐瞒真实情况随意填写等。

2.心理危机干预及时有效性弱

项目组在实地调研走访过程中了解到，心理健康服务在筛查评估方面主要存在以下问题：一是大部分学校都是在发生危机事件后才知道学生有心理问题。由于学校的心理测评主要依靠一年一次的普测（甚至有些学校是3年一次），所以无法及时了解到学生的心理健康状况，往往等到学生表现出自伤自残现象后才被动意识到学生出现问题。二是大部分学校仅依靠心理健康专职教师承担心理健康教育工作。我们发现只有少数学校的班主任和各科老师具备基础的心理健康知识学科渗透能力，大部分学校学生的心理健康教育都是由心理健康专职教师一人提

三、浙江省心理健康教育服务现存问题及原因

供的，这造成心理老师的巨大压力，无法保证工作的及时有效性。三是大部分学校的心理健康服务人员不具备足够的心理健康教育知识储备和相关技能。调研结果显示从事心理健康教育工作人员只有少数接受过专业的心理健康教育系统化知识培训，大部分老师报告自己在进行心理健康教育工作时存在无法胜任的情况。

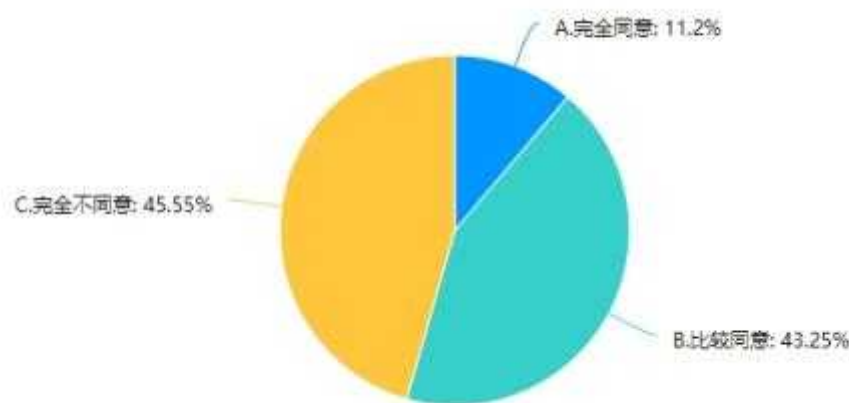


图 3-1 认为学校承担心理健康教育的主要责任统计图

3.心理健康服务体系整合性差

项目组在实地调研走访过程中了解到，心理健康服务在筛查评估方面主要存在以下问题：一是教育管理部门与其他部门缺少协调联动机制。目前心理健康教育工作由教育部门统筹管理，缺乏与其他部门之间的协同联动机制，造成教育部门工作压力过大。二是教育管理部门与地方高校缺少合作机制。教育行政部门与地方高校的合作少，而心理健康专业知识和专业人才主要由高校产出，没有良好的合作机制导致教育行政部门在落实心理健康教育相关举措时缺少专业性的保障和人才的持续补充。三是心理健康服务人员缺少分级分类培训。无法根据学生心理健康状况只能分解派遣任务，导致各方资源分散。心理健康教育需要国家、社会、学校多方力量的共同努力，这样才能更高效地提高学生心理健康水平。

三、浙江省心理健康教育服务现存问题及原因

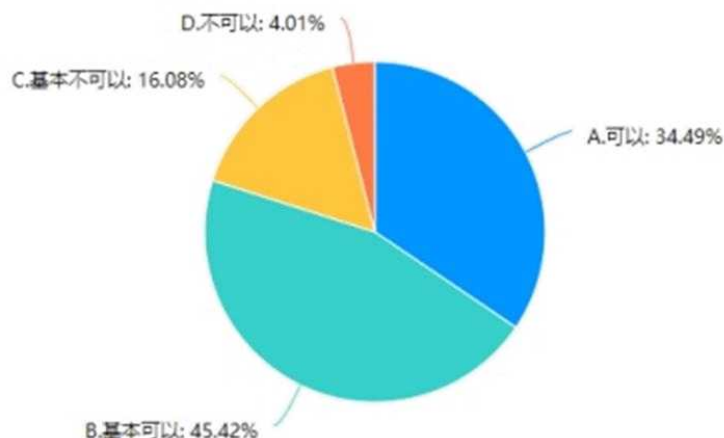


图 3-2 学校能精准提供心理干预统计图



图 3-3 影响老师参与心理健康教育工作的主要原因统计图

(二) 原因分析

1.政策落实不够到位

首先，心理健康服务责任主体单一。目前心理健康教育工作由教育部门统筹管理，缺乏与其他部门之间的协同联动机制。造成教育部门工作压力过大，其他部门即使想要出力也缺乏渠道。其次，学校心理健康服务人才缺乏。学校在落实心理健康教育相关举措时缺少专业性的保障和人才的持续补充。仅依靠心理健康专职教师无法完成全体学生的心理健康教育工作。最后，心理健康相关知识无专业统一学习渠道。心理健康服务人员缺少分级分类培训，无法根据学生心理健康状况只能分解派遣任务。家长、社会工作者等有意愿学习相关知识的群体缺少统一的系统专业学习渠道。

2.心理健康意识片面

首先,大部分人认为心理健康教育是治疗性的。其实心理健康教育是面向全体学生、培养学生积极心理品质,促进学生全面发展的。调查结果显示 1710 人认为心理健康教育服务对象为有严重心理问题的学生,24.1%的教师以及 22.54%的家长认为开展心理健康教育工作会影响学生的学习成绩。90.58%的人认为学生在遇到心理困扰后不主动寻求教师帮助的主要原因是担心被贴标签。说明大部分人对于心理健康教育的认识停留在矫正心理危机学生层面,没有意识到心理健康教育的发展性作用,学生在面对心理问题时存在病耻感。



图 3-4 学生不主动寻求心理帮助的原因统计图

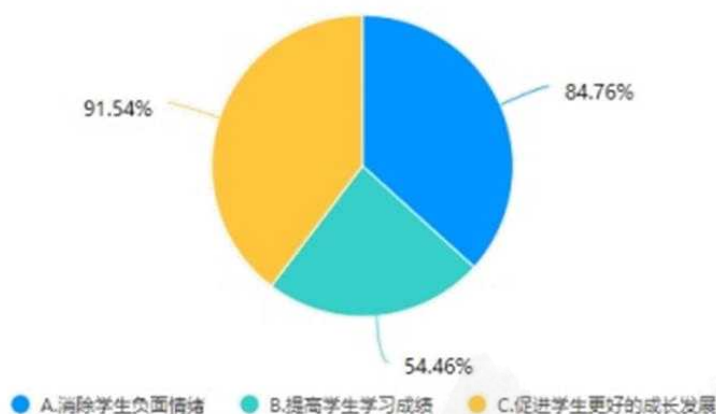


图 3-5 心理健康教育的作用统计图

三、浙江省心理健康教育服务现存问题及原因

其次，大部分人认为心理健康教育是学校和老师的工作。然而心理健康教育是需要家庭、社会、学校共同协作进行的。最后，大部分人认为心理健康教育是心理健康专职老师的工作。实际上，心理健康教育需要德育校长、班主任、各任课老师共同合作进行。通过校园文化的熏陶、各科老师的学科渗透教育，心理健康教育才能起到最好的效果。

3. 教师待遇保障缺乏

首先，心理健康专职教师专业性得不到尊重。我们发现大部分学校没有保障心理健康专职教师的课程，甚至有些学校要求心理健康教师教授其他科目。其次，心理健康专职教师工作压力大。我们发现大部分中小学的心理健康服务由心理健康专职老师独自负责，班主任和任课老师的心理健康教育知识匮乏，无法帮助心理健康专职教师分担工作。最后，心理健康专职教师工资低、待遇差、发展前景不光明。大部分中小学的心理健康老师工资待遇低于其余任课老师，并且在晋升方面的竞争远高于其余任课老师。

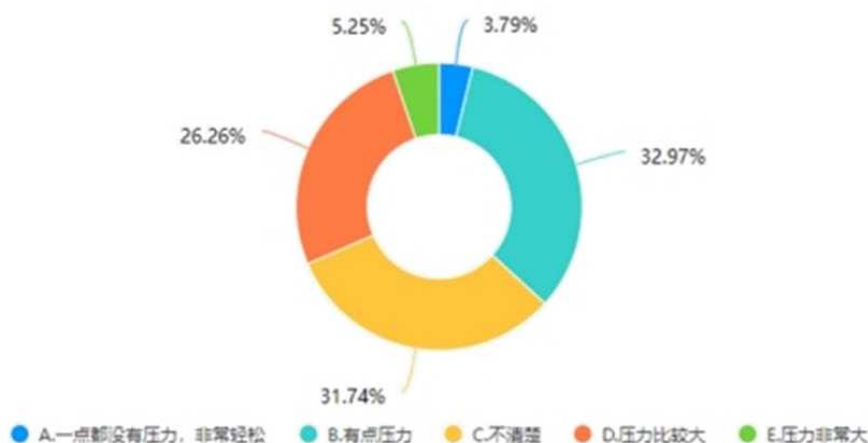


图 3-6 心理教师工作压力统计图

4. 筛查干预方法落后

首先，普测筛查精确度低。大部分中小学心理危机测评使用十几年前国外引进的 SCL-90 等风险因子问卷，并由学生主观填报，存在大量的误报、漏报的现

三、浙江省心理健康教育服务现存问题及原因

象。调查研究发现，68.8%的人对中小學生心理测量的精准性提出疑问，43.55%的人对中小學生心理测量的科学性提出疑问。其次，心理危机干预个性化低。大部分中小學的危机干预工作由心理健康专职教师承担，或是直接转介至医院。调查结果显示，大约有20%的人认为学校缺乏向不同心理健康状况学生提供个性化服务的能力。最后，学校没有科学完整的心理健康服务体系。大部分中小學没有形成德育校长、德育处主任和心理健康专职教师这样自上而下的体系，并且与学生有亲密接触的班主任和各科任课老师也不具备相关知识技能。

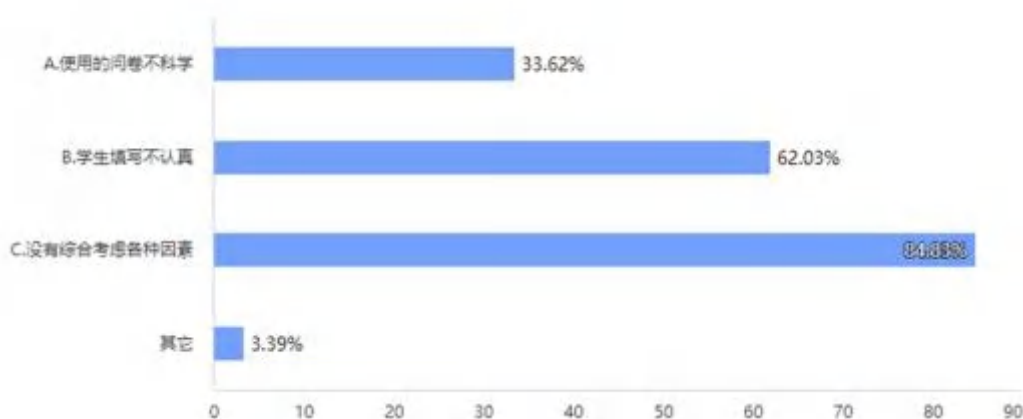


图 3-7 无法精准识别心理危机学生的主要原因统计图

四、数字化心理健康服务体系新模式

心理健康教育数字化是实现心理赋能与数字赋能双重赋能的必由之路。综合考虑技术、服务措施以及顶层设计，开发数字化心理健康服务体系新模式，做到心理健康教育即时性、精准性、高效性的有机统一。不仅消除学生的心理问题，还培养其积极品质，帮助开发其潜能。

在技术上，通过大数据、机器学习等方式，将来自风险因子、保护因子以及诱发因子这不同维度、不同来源、不同模态的数据整合在一起。实现对学生心理健康精准画像与动态发展轨迹，真正做到学生心理危机的精准识别。

在服务措施上，通过建立智慧实验室的方式，对不同学生将心理服务任务及时有效的分配给对应服务人员，实现全面连接互通、即时交互。此外，依靠机器模拟、人工智能能够给老师、家长、领导提供针对性切实有效的心理服务指导，最终实现智能干预。

在顶层设计上，夯实县域心理健康服务顶层设计，建立健全区县市委教育工作领导小组直接领导的中小学心理健康教育工作联席会议，形成各部门资源整合畅通机制。合理配置公共资源，协调加强未成年人心理健康教育促进平安健康成长工作。

（一）大数据提升筛查评估精准度

根据深度图注意力网络算法，采用数学建模的方式整合不同维度、不同来源、不同模态的数据，建立多模态数据支持下的未成年人心理健康水平核心算法。结合大数据分析，锚定整个区县危机学生比例，实现学生心理健康精准画像与动态发展轨迹可视化。以往关于中小学学生心理危机的评估往往是采用风险因子有关的自我报告，但是仅仅依靠风险因子的测评工具很容易导致学生心理危机测评的“错报”“漏报”。

通过理论分析和实证研究，我们以系统思维提出了“风险累积—正向支持”心理危机干预辩证模型，强调危机的产生由诱发因素直接导致，风险因子起到

四、数字化心理健康服务体系新模式

累积催化的作用，积极因子作为削弱心理危机的保护因子。采用数学建模、算法智能迭代的方式整合不同维度、不同来源、不同模态的数据，并且将整个区县学生的心理状态数据进行汇总。

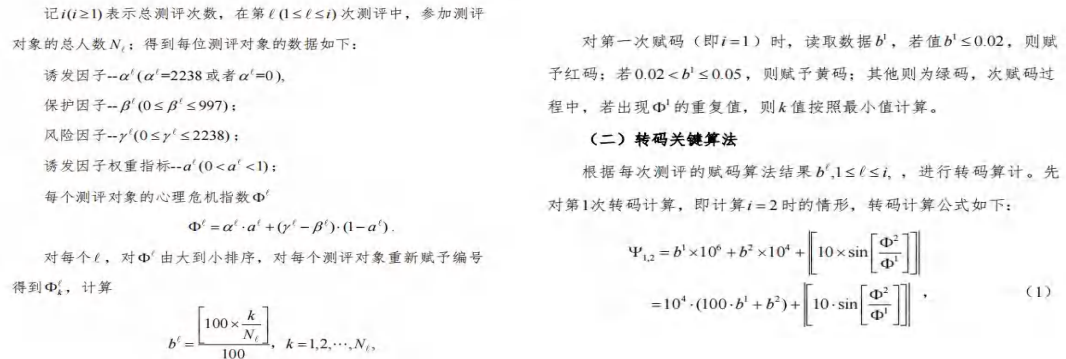


图 4-1 未成年人心理健康水平部分核心算法图

根据国际心理危机发生率和我们的实践研究结果，我们认为对于前 15% 的人群都应该进行额外的心理服务，对于前 2%-5% 的人群要提供专门性心理服务。根据以上标准，我们对中小学学生的心理健康状况进行赋码，分别为重度心理危机人群赋红码（<2%），中度心理危机人群赋黄码或橙码（2%~5%），其余人员赋绿码（>5%），实现了对龙游县中小学学生的精准评估。



图 4-2 “风险累积—正向支持”心理危机干预辩证模型图

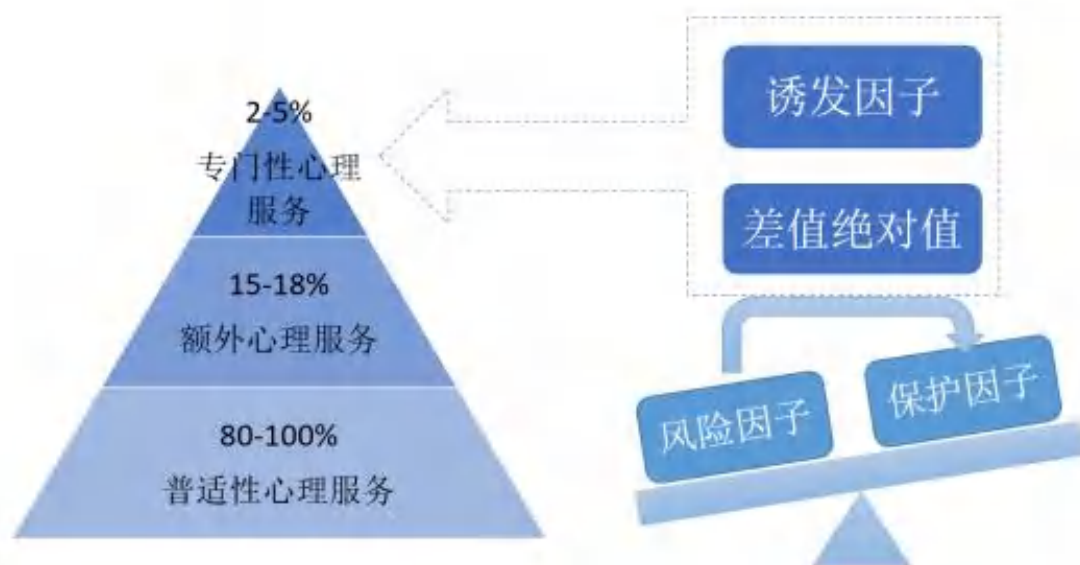


图 4-3 心理危机指数指标示意图

（二）人工智能增强干预服务有效性

通过人工智能、大数据、数字化等技术手段建立智慧实验室。这样不仅能够将整个区县的学生数据进行汇聚整合分析，更能够实时监控学生心理情绪变化，针对不同学生将心理服务任务及时有效的分配给对应服务人员，实现全面连接互通、即时交互。此外，依靠机器模拟、人工智能能够给老师、家长、领导提供针对性切实有效的心理服务指导，最终实现智能干预。

以往人们认为任何烦恼、焦虑等心理方面或可能是心理方面的问题都只能求助于心理专职老师，这不仅严重加大心理老师的负担，更会导致学生心理干预的效率急剧降低。借助大数据与人工智能等主要技术手段，在龙游县建立智慧实验室，实时分析学生心理状态变化，并及时反馈给对应服务人员。这一举措实现对服务总目标的分解，进而达到心理服务即时性、精准性、高效性的有机统一。依靠人工智能、机器模拟等手段，对服务人员进行高效专业的培训。

总的来说，对于学校分管校长而言，应当培训他们掌握心理健康教育的核心理念成为学校心理健康教育的缔造者、推动者和执行者，为学校实现更好的心理健康教提供保障。对于班主任老师而言，作为与学生在学校中接触最为直接密切的群体，应当培训他们提升心理健康知识的储备，确保做到准确识别学生问题并

四、数字化心理健康服务体系新模式

且掌握基础的心理辅导方式。对于各个学科老师，应当培训他们了解学生的身心发展规律，将心理健康教育理念融入到课堂课程中，并且需要初步掌握心理健康问题筛查和判断的能力。对于心理健康专职老师，他们作为学校心理健康教育的专业力量、主力军，应当培训他们提升心理咨询方面的专业能力以及对心理健康教育的思维方式，成为心理健康教育的名师。对于学生家长，作为与学生联结最为密切的群体，应当培训家长们的沟通能力和识别能力，提高与孩子之间的表达和沟通能力。对于社区干部，应当培训他们掌握基础的家庭问题调节与指导能力，以及基本的心理危机处理方法，保证当有危机事件出现时能够及时进行帮助。充分发挥家长的榜样作用，心理健康专职老师的引导作用，班主任老师的主体作用，任课老师的基础作用，校长的领衔推动作用，以及社会各方的支持作用。



图 4-4 龙游县学生成长中心一角

(三) 流程再造统筹服务部门整合力

通过数字化流程实现对学生心理服务智能分解目标与精准派遣任务。以心理健康教育小组的形式使各部门各司其职相辅相成，保障高效的心理服务。对各服务人员进行分层培训，实行专人专项工作，在保证生命安全、心理健康的

四、数字化心理健康服务体系新模式

基础上，帮助学生开发潜能，提高综合素质。

以往中小学心理健康教育工作被认为是教育部门的职责，这导致教育部门独挑大梁，其他部门有力不能使状况，严重危害到了心理健康教育的有效进行。因此，我们提出成立由教育部门领导的心理健康教育工作小组，通过数字化流程实现对学生心理服务智能分解目标与精准派遣任务，充分调动各方力量资源，让各个部门各司其职相辅相成。整合心理健康公共辅导与个别干预为一体，充分发挥学校校长、班主任、学科老师、心理专职老师、家长以及社区干部等其他重要群体的作用。公共辅导方面，通过与浙里办挂钩，采用线上线下结合的方式，在线上、学校、社区为学生提供一些基础的心理咨询及讲座。个别干预方面，对“红码”和“黄码”学生进行专门性心理服务，进行生命教育。此外对于“红码”和“黄码”的心理危机学生基于四次大数据动态追踪和每学年的简易数据进行定期研判，专人负责跟进，协同相关人员共同辅导。按照师生比 1:10-1:20 的比例安排专职心理辅导教师全程跟进，实施“守门人”计划（顾问教师计划）。对“橙码”学生进行额外心理服务，对他们进行压力疏导；对“绿码”学生进行普适性心理服务，尽可能提升他们的积极品质，在守护学生生命安全、心理健康的底线基础上，培养学生的综合素质的提高，帮助他们掌握科学的学习方法、养成积极的学习态度。每一位学生在三观塑造、知识获取、技能养成、素养培养方面成长得更快、更优、更健康，实现心理服务从矫正走向发展的服务改革。



图 4-5 家校社联动，共同成长

五、应用成效

(一) 风险累积-正向支持心理危机干预辩证模型服务 中小学心理危机精准识别与智能干预

依托走心驿站数字化机制，借助多模态数据分析技术融合核心评估指标（诱发因子、风险因子、保护因子），通过学生、家长、教师三方评估以及浙里办数字化平台提供数据，产出精准、科学的心理危机识别与预警。依托数字化平台推广，推进心理素养画像过程囊括更多信息，包括学生家庭背景、家族病史等，促进技术手段迭代；介入发展轨迹图描绘技术，每学年安排结构化心理测评揭示心理状态演变趋势，定义、识别学生优势成长点，动态赋码转码。坚持学年综合心理评估机制，分学段锚定不同干预手段对象学生比值，提供靶向心理干预手段建议，包括多维度心理咨询及讲座、心理健康教育特色主题活动、以及安排专职心理教师一对一跟进等。



图 5-1 走心驿站数据驾驶舱

学生分类	服务分级	课程重点	活动重点		
红码 黄码	专门性心理服务	生命教育	心理咨询	团体辅导	家长 工作坊
橙码	额外心理服务	压力疏导			
绿码	普适性心理服务	积极品质	心理运动会		
			心理文化节		

图 5-2 心理服务能力图谱



图 5-3 教师培训现场

(三) 家长成长工作坊提升家长心育水平

以加强家长修养，注重言传身教为主旨，开展家长工作坊，使用精品课程、操作实践、意见反馈、反思梳理等方式，在家庭层面推动心理健康教育普及，培养家长共情技能。推出家长学习积分制，将家长学习进度量化评估，直观揭露学习短处，针对性提供相应学习资源，确保家长课程教学效果，以良好的品行、适当的方法教育和影响未成年人。搭建省级积极心理品质培养课程资源平台，面向家长设置心理辅导活动课、心理微课、校园心理剧等版块，推出视频课程 75 个、微视频 196 个，浏览量高达 2530.3 万，打破家校社壁垒，形成整体推进合力。



图 5-4 家长培训现场图

六、未来展望

聚焦当前社会存在心理危机筛查“误报”“漏报”现象，危机干预延时低效现象以及心理健康服务体系割裂现象，我们项目组探索并完善了数“智”化心理健康服务体系，创新数字化改革应用场景建设，用数字赋能撬动心理赋能。首先，我们使用多源数据提升筛查研判精准度，精确刻画未成年人心理健康综合画像与可视化动态发展轨迹。其次，我们研发智能算法增强分级服务有效性，用算法技术智能匹配不同层级心理服务需求与心理服务人员。接着，我们推动流程再造统筹协同重塑心理服务体系，实现心理健康服务全覆盖，体系化。最后，我们促成制度重塑，通过中小学与地方高校心理学专业教授博士团队合作，推进心理健康教育管理精益化，家校服务精准化。

在未来我们希望通过数“智”赋能下的心理健康教育服务新模式来推动全国心理健康教育服务改革，通过全省心理健康教育服务领域实现共建共享，最终实现共同富裕。

（一）浙江省心理健康教育服务新模式推动全国心理健康教育服务改革

“走心驿站”方案在龙游试点并取得成效后，本团队立即着手推广工作。到2022年底，本团队就龙游样本与桐乡、浦江和乐清等地合作完成当地心理健康服务数字化改革，辐射惠及172所中小学，覆盖80万名中小學生。在桐乡，我们开展了“阳光桐乡”心理服务项目，探索家校共育新模式，培养心育队伍，形成人人善于辅导的局面；在浦江，我们研发“心路e通”心理健康管理系统，保

六、未来展望

障未成年人心理健康成长、快乐成长；在乐清，我们研发心理健康危机预警系统，利用计算机做到及时识别危机。未来我们期望将项目推广至全省，在各地形成“人人善于辅导，人人接受辅导，人人心理健康”的心理服务格局。



图 6-1 龙游样板推广图

（二）山区 26 县反哺推动全省心理健康教育服务领域实现共建共享和共同富裕



图 6-2 数智化心理健康服务实践图

龙游县“走心驿站”上线浙里办，入选教育部信息技术与教育教学深度融合示

六、未来展望

范案例，纳入浙江省数字改革一本账。改革成效推动了浦江县“心路 e 通”心理健康数字化管理系统落地，松阳县“舒心码”数字改革方案实施，带动全国百强县桐乡市、诸暨市开展“阳光桐心”“幸福诸暨”等区域心理服务项目。26 县通过共享改革的方法和成果，引领其他较发达地区共同建设数字化心理健康服务体系新模式，从而推动全省心理健康教育服务领域。通过全省的共同发展，实现山区落后地区也能在心理健康教育服务体系对其他地区的引领作用，最终实现“共同富裕”。

参考文献

- [1] 窦媛, 乔东平. “家校社协同”视域下家庭教育指导服务体系顶层设计与实施策略[J]. 中国教育学刊, 2023(01): 34-39+74.
- [2] 黄春梅. “最近发展区”的多重动态关系解读与澄清[J]. 教育科学研究, 2016(12): 65-67. [1] 黄春梅. “最近发展区”的多重动态关系解读与澄清[J]. 教育科学研究, 2016(12): 65-67.
- [3] 贾支正, 张钰. 系统论视域下大中小学思政课一体化建设探析[J]. 系统科学学报, 2022, 31(03): 116-120.
- [4] 蒋立兵, 季春晓. 反思性实践视域下教师工作坊研修过程模型研究[J]. 中国电化教育, 2018(11): 39-45.
- [5] 冒巍巍, 邢博, 陈方玺. 基于协同理论的高校校友服务体系建设与研究[J]. 中国第三部门研究, 2021, 21(01): 105-125+258-259.
- [6] 聂妮. 学前教育专业学生核心素养体系模型建构——以系统论为视角[J]. 教育科学探索, 2022, 40(04): 65-73.
- [7] 彭帆, 韩立敏. 心理危机的保护性因素研究进展(综述)[J]. 中国健康心理学杂志, 2023, 31(03): 326-330.
- [8] 孙佳佳, 杜冰. 一般系统论视域下通信原理课程思政体系的建构研究[J]. 北京科技大学学报(社会科学版), 2020, 36(04): 112-118.
- [9] 孙晓红, 韩布新. 国内外流动儿童青少年心理健康状况研究: 基于 CiteSpace 的可视化分析[J]. 中国青年研究, 2018(12): 67-73.
- [10] 王歆睿, 韩布新. 基于微信平台的研究生积极心理干预[J]. 心理科学, 2023, 46(01): 230-237.
- [11] 王志伟. 协同理论视域下研究生导师立德树人研究[J]. 思想教育研究, 2022(03): 147-152.
- [12] 谢璐. 双因子模型下不同组别青少年心理健康动态性追踪研究[D]. 湖南师范大学, 2017.
- [13] 姚远, 程诚. 同伴网络与青少年心理健康[J]. 青年研究, 2021(05): 24-34+95.

- [14]殷宝媛,陈丽.在线教育自组织系统的科学原理与趋势分析[J].电化教育研究,2018,39(03):56-61.
- [15]余维新,顾新,熊文明.产学研知识分工协同理论与实证研究[J].科学学研究,2017,35(05):737-745.
- [16]张鸣哲,张京祥,何鹤鸣.基于协同理论的城市众创空间集群形成机制研究——以杭州市为例[J].城市发展研究,2019,26(07):29-36.
- [17]赵献梓,王剑彪.学校心理健康教育结合家庭干预对中学生心理健康的影响[J].中国学校卫生,2021,42(03):408-411.
- [18]Bronfenbrenner, U. The ecology of human development[M].Cambridge:Harvard University Press,1979.
- [19]Campione, J. C., Brown, A. L., Ferrara, R. A., & Bryant, N. R. The zone of proximal development: Implications for individual differences and learning. *New Directions for Child and Adolescent Development*, 1984,(23): 77 – 91.
- [20]El-Hage, W., Philippe, J. L., Ferreri, F., Benoit, M., Vidailhet, P., Prieto, N., François, I., Baubet, T., & Vaiva, G. Improving the mental health system for trauma victims in France.[J]. *European journal of psychotraumatology*,2019: 10(1).
- [21]Golofast, A. V. (2020). Synergetics of Political Processes of Philosophy of the Russian Academy of Sciences. *Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta*, 2022,(459), 107–112.
- [22]Hasse, C. Institutional creativity: The relational zone of proximal development. *Culture & Psychology*, 2001, 7(2): 199 – 221.
- [23]Herman, H. Synergetics[J]. *Physics Bulletin*,1977,28(9):412-414.
- [24]Kidd, S, Henrich, C. C, Brookmeyer, K. A., et al. The social context of adolescent suicide attempts: :Interactive effects of parent, peer, and school social relations[J].*Suicide and Life-Threaten-ing Behavior*, 2006,36(4): 386-395.
- [25]McLennan, P. A., Laba, T. M., & Nakamura, B. J. Effects of Modularized Workshop Trainings on Youth Clinical Progress in a Public Mental Health System[J]. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders*,2023,31(1).
- [26]Miao, J. H., Tao, W. Z., & Qi, Y. (2018). Research on the Innovation of College

Students' Ideological and Political Education Based on the Synergetics Theory.
Educational Sciences Theory& Practice, 2018,18(5), 2478-2485.

[27]Pickering, M. J., & Garrod, S. Toward a mechanistic psychology of dialogue[J].
Behavioral and brain sciences,2004,27(2):169-226.

[28]Peters, B. Managing horizontal government[J].Public Administration,
2002,76(2):295-311.

[29]Reist, C., Petiwala, I., Latimer, J., Raffaelli, S., Borish, C. M., Eisenberg, D., &
Campbell, S. Collaborative mental health care: A narrative review[J].
Medicine,2022,101(52):e32554-e32554.

[30]Renu, Y. Strengthening Alliance for Psychological Well-Being of Students[J].
International Journal of Social Sciences Review,2018,6(3):320-323.

[31]Rogoff, B. Cognitive development through social interaction: Vygotsky and
Piaget[J]. Learners, learning and assessment, 1999: 69-82.

[32]Rugkåsa, J., Tveit, O. G.,Berteig, J., Hussain, A., & Ruud, T. Collaborative care
for mental health: a qualitative study of the experiences of patients and health
professionals.[J]. BMC health services research,2020,20(1): 844-844.

[33]Shokouhi, M, Shakouri, N. Revisiting. Vygotsky's concept of zone of proximal
development: Towards a stage of proximity[J]. International Journal of English
Literature and Culture, 2015, 3(2): 60-63.

[34]Sundet, R., Kim, H. S., Karlsson, B. E., Borg, M., Sælør, K. T., Ness, O. A
heuristic model for collaborative practice-part 2: development of the
collaborative, dialogue-based clinical practice model for community mental
health and substance abuse care.[J].International journal of mental health
systems, 2020, 14(1):43.

[35]Tanya, H. I., Manion, S. N. Iyer, S., Mathias, R., & Purcell, J. H. Trends in mental
health system transformation: Integrating youth services within the Canadian
context[J]. Healthcare Management Forum,2019,32(2).

[36]Van der, V. R., & Valsiner, J. Overcoming dualism in psychology: Vygotsky"s
analysis of theories of emotion. Quarterly Newsletter of the Laboratory of

Comparative Human Cognition, 1989, 11(4):124-131.

[37]Vygotsky, L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Functions[J]. Russian Social Science Review, 1977, 18(3):38-51.

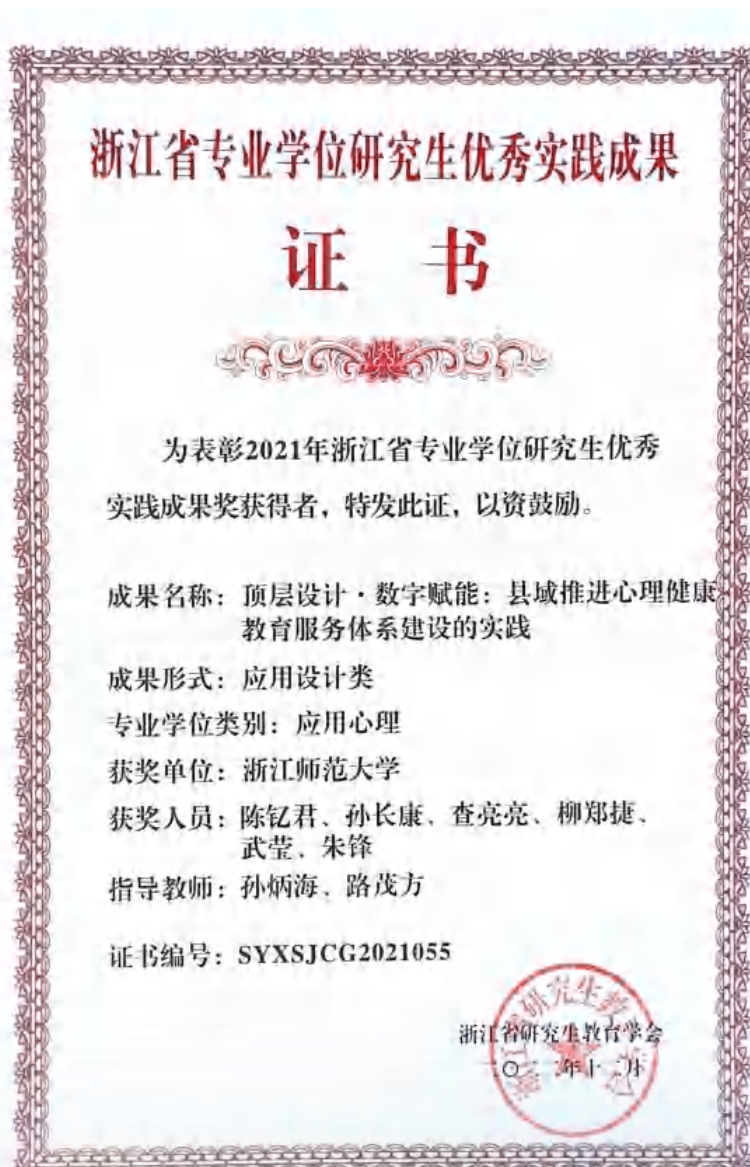
[38]Xi, J., & James P. L. "Scaffolding and the zone of proximal development: A problematic relationship." Journal for the Theory of Social Behaviour,2021, 51.1: 25-48.

[39]Xiu Z. H. Development and Application of Professional Women Physical Fitness and Mental Health Detection System[J]. Advanced Materials Research,2011,12(90):271-273.

附录

一、所获荣誉及成果展示

1. 《顶层设计·数字赋能：县域推进心理健康教育服务体系建设的实践》或浙江省专业学位研究生优秀实践成果



2. 浙江省省委宣传部将龙游县“走心驿站”青少年心理健康服务应用体系列入第二批全省宣传文化系统重点应用。

中共浙江省委宣传部

关于公布第二批全省宣传文化系统重点应用的通知

各市、县（市、区）委宣传部：

为持续迭代推进宣传文化领域数字化改革，全面发现、培育一批具有宣传味、改革味的应用成果，根据部领导指示要求，我们对照省数字化改革“一本账S₁”跑道，征集了一批由市、县（市、区）建设并已上线的数字化应用，经相关处室、专家评审，部数字化改革专题会议研究审议，择优确定宣传文化领域第二批重点应用11个。

各市、县（市、区）要深入贯彻落实全省数字化改革推进会精神，持续抓细抓实“三张清单”，加强与省“一本账S₁”重大应用的对接，打造好用管用实用、体现宣传味、改革味的应用场景，为全省宣传文化智融工程建设贡献力量。

联系人：段丹，联系电话：15372585562。

附件：第二批全省宣传文化系统重点应用名单

中共浙江省委宣传部
2022年11月11日

附件

第二批全省宣传文化系统重点应用名单

序号	应用名称	功能描述	建设主体	对应S ₁ 应用
6	“走心驿站”青少年心理健康服务应用体系	针对青少年心理健康服务存在的资源未贯通整合、服务队伍力量薄弱、协同联动机制不完善、个人信息管理数据等问题，建设数据融合、心理测评、心理咨询、生命守护、预防预防、危机干预、数字宣教等七大模块，开发六维闭环系统，科学验证并精准设计心理干预机制，多渠道充实心理健康服务专家资源，打造了集预防青少年心理健康九大模块应用体系，构建了心理健康部门联动共育生态服务与治理模式。	衢州市、龙游县	青少年心理健康保护应用

中央人民政府 浙江省人民政府 衢州市人民政府 浙江政务服务网 阅读辅助 English 数据统计 智能问答 繁体 用户中心 办件统计

龙游县人民政府

WWW.LONGYOU.GOV.CN

请输入关键词查询

首页 政务公开 政务服务 网络问政 走进龙游 新媒体 进入老年模式

当前位置：政务公开 > 决策公开 > 规范性文件

检索索引号：00250238/2022-142168 公开方式：主动公开

文号： 公开日期：2022-07-20

发布单位： 县府办 有效性：

统一编号：

2022年县政府重点工作1-6月完成情况

发布时间：2022-12-20 17:31 浏览次数：114

一、李兰兵县长牵头重点工作

1.全县生产总值增长6.5%以上；固定资产投资增长10%；社会消费品零售总额增长9%；一般公共预算收入增长10%；城镇和农村居民人均可支配收入分别增长9%和11%；城镇登记失业率控制在3.5%以内；节能减排降碳完成年度目标任务。

责任单位：资源规划局、林水局、发改局、住建局、文广旅体局、财政局、经信局、科技局、招商投资促进中心、城投公司、文旅公司、经济开发区、相关乡镇（街道）

完成情况：《龙游湖环湖地区高质量发展规划及城市设计》已形成阶段性成果。

七、舒建明副县长牵头重点工作

1.加强智慧医保建设。

责任单位：医保局

完成情况：实现医保参保征缴工作全覆盖，加快医保基金综合监管数字化转型，完成全县109家定点零售药店和诊所类定点医疗机构“医保定点医疗机构智能监控系统”升级。建立医保基金先行支付追偿新机制，防范参保人道德风险及经办机构的经办风险。举办医疗保障政策业务培训会和医疗保障能力提升培训。

2.推动全民健康信息互联。

责任单位：卫健局

完成情况：完成全民健康信息平台二期建设，迭代升级基层医疗机构的HIS、健康档案、电子病历、公共卫生系统，完成各类医疗机构业务数据归集和RIS平台数据上传工作。

3.完善生育支持政策体系，发展普惠托育服务。

责任单位：卫健局

完成情况：完成新增3家普惠乡镇（街道）建有托育机构，新增托位数3岁以下婴幼儿托位320个（均为普惠性托位），截至目前，幼儿园托班登记34家，总托位数1410个，每千人口拥有婴幼儿照护机构托位数达到3.9个。

4.启动教育提升工程，大力实施“三三工程”，加快推进龙游中学改扩建、开发区高新园区实验学校、龙洲街道中心幼儿园等项目，确保公办园、优质园覆盖率分别达到55%和75%以上。

责任单位：教育局

完成情况：大力实施“三三工程”，积极谋划第二期“三三工程”教师培养计划，有序推进学校提升改造，龙中改扩建一区4栋教学楼基础施工中，高新园区实验学校教学楼主体施工中，其他楼栋基础完工；柳园小学三期基础完工，暑期完成4个中心幼儿园扩园提升项目。全市率先发布义务教育段招生方案，基本形成“民转公”学校非编教师安置方案。有序推进30所左右“低小撤”民园引退工作，并启动收购2-3所优民民办园。

5.落实教育“双减”政策，治理校外培训机构，规范学校课后托管服务，加强学生心理健康教育。

责任单位：教育局

完成情况：共建成省级劳动实践基地2个，省劳动教育实践校1个，3位教师、2位学生被评为市有礼貌之星称号。推进校内课后托管服务，形成“5+1+X”特色做法，抓好“第二时段课程”建设，推动课程资源实现校外向校内补充，活动时间由原来的1.5小时延长至2小时，课后托管服务覆盖率由原来的70%提升至100%，课后托管服务覆盖率由原来的70%提升至100%。

部门联合宣告互动、违法线索互联、监管标准互通、处理结果互认，持续推动校外培训机构健康发展。开发打造“走心驿站”青少年心理健康服务应用项目，该应用被教育部评为基础教育信息化区域示范案例，被省委宣传部列入第二批全省宣传文化系统重点应用。

6.推进健康龙游建设，做实做强医联体、医共体，加快健康产业园、妇女儿童健康医院项目进度。

45

3. 浙江省委宣传部将龙游县“走心驿站”青少年心理健康服务应用体系评为数字文化系统第四批优秀应用

2022年11月30日，浙江省委宣传部公布了数字文化系统第四批优秀应用，龙游“走心驿站”未成年人心理健康服务应用榜上有名。

数字文化系统第四批优秀应用名单

序号	应用名称	建设单位
1	融媒通	浙江日报报业集团
2	钱塘BAO物	杭州市园文局
3	临享·文化保障卡	杭州市临平区文化和广电旅游体育局
4	新安堂前燕	建德市委宣传部
5	文物雨安	宁波市文广旅游局 海曙区文广旅体局
6	“新生代”国际传播力量 窗口通	文成县委宣传部
7	浙里安管	安吉县文化和广电旅游体育局
8	盐迹拾遗	海盐县委宣传部 海盐县文广旅体局
9	孝德志愿在线	绍兴市上虞区委宣传部
10	意识形态安全监管 (金意安)	金华市委宣传部
11	共富百花云	武义县委宣传部 武义县文化和广电旅游体育局
12	走心驿站	龙游县委宣传部 龙游县教育局
13	海岛文e家	舟山市委宣传部
14	浙里有戏	临海市人民政府
15	畲乡非遗共富	景宁县委宣传部 景宁县文广旅体局

4. 浙江省教育厅办公室将龙游县“走心驿站”青少年心理健康服务系统项目纳入教育领域数字化改革第一批创新试点项目



浙江省教育领域数字化改革第一批创新试点项目			
序号	业务领域	项目名称	试点地区/高校
31	职业教育	“东迁西归”乡村振兴背景下职业教育东西部协作系统	永康市
32	就业服务	“回网里”大学生引智回乡系统	衢州市
33	课后托管	“课后归巢”延时托管服务系统	柯城区
34	智慧食堂	数字校园智慧食堂系统	衢江区
35	儿童关爱	留守儿童关爱“一件事”系统	常山县 开化县
36	心理健康	“走心驿站”青少年心理健康服务系统	龙游县
37	劳动教育	“慧劳动”区域新时代劳动教育管理系统	江山市
38	老年教育	老年开放教育公共服务系统	舟山市
39	职业教育	数字职教管理云中心系统	台州市
40	学生健康	物联网学生近视防控系统	台州市椒江区
41	教育均衡	区域教育共同体系统	三门县
42	教育均衡	基于新型城乡教育共同体的乡村名校云系统	天台县
43	全民学习	“仙学汇”数字乡村社区学校服务系统	仙居县
44	全民学习	社区教育在线服务系统	温岭市
45	项目管理	教育基建智能化管理系统	临海市
46	资源规划	教育资源保障动态监控系统	玉环市

5. 龙游县“走心驿站”列入教育部信息技术与教育教学深度融合示范案例

关于2021年度信息技术与教育教学深度融合示范案例名单的公示

各省、自治区、直辖市教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局：

为深入贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神，总结推广地方和中小学推进信息技术与教育教学深度融合的经验做法，促进信息技术与教育教学融合创新，加快推进基础教育现代化，推动基础教育高质量发展，我司组织各地逐级推荐信息技术与教育教学深度融合的典型案例，并组织专家对各地推荐案例进行评审，根据评审结果，拟确定44个学校和66个区域信息技术与教育教学深度融合示范案例，现将名单予以公示。

公示期为2022年1月26日-1月30日。期间，对入选案例如有异议，请以书面方式正式提出，并提供必要的证明材料、真实个人信息、有效联系电话和地址，同时将相关材料扫描或拍照后发至联系邮箱。逾期不予受理。

联系电话：010-66097815

电子邮箱：jzc@moe.edu.cn

地址：北京市西城区大木仓胡同37号，100816

附件：[2021年度信息技术与教育教学深度融合示范案例名单](#)

教育部基础教育司

2022年1月26日

省份	区域名称	案例主题
上海市	黄浦区	面向数字化转型的名师学习指导
江苏省	江苏省	江苏省名师空中课堂案例
江苏省	常州市	为未来而学：整体推进“智慧教育”视域下的数字化学习实践探索
浙江省	浙江省	浙江省构建高质量教育资源公共服务体系及全域推进“大数据精准教学”
浙江省	衢州市江山市	为新时代劳动教育植入“智慧基因”
浙江省	舟山市岱山县	开好“船”，架好“桥”-岱山县“数字赋能”打造城乡教育共同体海岛新样
浙江省	衢州市龙游县	龙游县“走心驿站”青少年心理健康服务应用体系
浙江省	东阳市	融入体系提服务创新模式促变革
浙江省	金华市	“五位一体”的课后托管平台及创新应用
安徽省	蚌埠市	数据驱动，因材施教
安徽省	合肥市	合肥市数据驱动基础教育育人方式改革的探索与实践
福建省	漳州市	不动声色的课堂革命
江西省	江西省	“智慧作业”为落实“双减”提供技术赋能
山东省	青岛市	创新与引领—人工智能课程普及开创青岛模式
山东省	济南市	大数据驱动区域教育质量整体提升
山东省	烟台市	区域网络视频教研体系的构建研究
山东省	潍坊市	以融合创新驱动学生信息素养攀升

6. 龙游县“走心驿站”被教育部评为全国基础教育信息化区域示范案例

2021年度基础教育信息技术与教育教学融合示范案例公布

2022-02-23 来源：教育部 ☆收藏

为深入贯彻落实党的十九大及十九届中央历次全会精神 and 全国教育大会精神，总结推广地方和中小学推进信息技术与教育教学深度融合的经验做法，促进信息技术与教育教学融合创新，加快推进基础教育现代化，推动基础教育高质量发展，教育部组织开展了2021年度基础教育信息技术与教育教学深度融合典型案例的评审工作，共有66个区域和44所学校被评为示范案例。

这些示范案例展现了近年来各地各校在信息化硬件建设与应用、数字化资源建设与应用、智能化工具平台建设与应用、智慧课堂、空中课堂、作业辅导、课后服务、教师研修、综合评价等具体教育教学场景的融合应用，体现了信息技术在支持智能化、数字化、精准化、个性化教与学过程中的重要作用，凸显了信息化在创造性地解决教育改革与发展中的问题、推进教育公平、助力教育治理、提高教育质量中的重要作用。其中，区域示范案例覆盖了省、市、县三级，主要集中在“加强优质资源建设与应用”“促进教师专业发展”“提高区域教育治理水平”“注重区域教育均衡发展”等方面；学校示范案例内容主要涉及信息技术在校本课程建设、课堂教学、学习支持、综合评价等方面的具体做法。

示范案例都是区域和学校从实际需求出发，探索利用多种信息技术手段解决教育教学有关领域、阶段、环节遇到的突出问题，具有融合性、实效性、创新性。教育部将进一步推广示范案例，加强应用指导，充分利用信息化服务学生学习、服务教师改进教学、服务优质资源共享，服务教育治理现代化，推动更多地区和学校积极探索现代信息技术与教育教学的创新融合发展之路。

2021年度基础教育信息技术与教育教学深度融合示范案例名单

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

省份 ^❷	区域名称 ^❷	案例主题 ^❷
黑龙江省 ^❷	哈尔滨市阿城区 ^❷	数据驱动下的区县级精准教研模式 ^❷
上海市 ^❷	宝山区 ^❷	乘时代之风·助教学之变-宝山区数字教材应用推区域推进 ^❷
上海市 ^❷	闵行区 ^❷	区域智慧教育云平台的实践与探索 ^❷
上海市 ^❷	浦东新区 ^❷	基于数字基座的区域教育数据治理与创新应用实践 ^❷
上海市 ^❷	黄浦区 ^❷	面向数字化转型的名师学习指导 ^❷
江苏省 ^❷	江苏省 ^❷	江苏省名师空中课堂案例 ^❷
江苏省 ^❷	常州市 ^❷	为未来而学：整体推进“智慧教育”视域下的数字化学习实践探索 ^❷
浙江省 ^❷	浙江省 ^❷	浙江省构建高质量教育资源公共服务体系及全域推进“大数据精准教学
浙江省 ^❷	衢州市江山市 ^❷	为新时代劳动教育植入“智慧基因” ^❷
浙江省 ^❷	舟山市岱山县 ^❷	开好“船”、架好“桥”-岱山县“数字赋能”打造城乡教育共同体海岛新样机
浙江省 ^❷	衢州市龙游县 ^❷	龙游县“走心驿站”青少年心理健康服务应用体系 ^❷
浙江省 ^❷	东阳市 ^❷	融入体系提服务创新模式促变革 ^❷
浙江省 ^❷	金华市 ^❷	“五位一体”的课后托管平台及创新应用 ^❷
安徽省 ^❷	蚌埠市 ^❷	数据驱动，因材施教 ^❷
安徽省 ^❷	合肥市 ^❷	合肥市数据驱动基础教育育人方式改革的探索与实践 ^❷
福建省 ^❷	漳州市 ^❷	不动声色的课堂革命 ^❷
江西省 ^❷	江西省 ^❷	“智慧作业”为落实“双减”提供技术赋能 ^❷
山东省 ^❷	青岛市 ^❷	创新与引领—人工智能课程普及开创青岛模式 ^❷

7. 龙游县“走心驿站”青少年心理健康服务应用体系入选《浙江省中小学心理健康教育典型案例》一书

我们的2021|这一年，龙游教育闪闪亮

龙游智慧教育 2022-01-14 21:03 发表于浙江

九

这一年， 数字赋能教育“有作为”

浙江省教育厅

浙教办函〔2021〕145号

浙江省教育厅办公室关于公布领域数字化改革第一批创新试点项目的通知

各市、县（市、区）教育局，各直属学校：

根据《浙江省教育领域数字化改革三年行动方案》《2021年浙江省教育领域数字化改革工作要点》，经教育厅组织各地申报、遴选，确定第一批创新试点项目，现予公布。

序号	实施领域	项目名称	试点单位/学校
11	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
12	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
13	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
14	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
15	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
16	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
17	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
18	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
19	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
20	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
21	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
22	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
23	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
24	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
25	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
26	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
27	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
28	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
29	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
30	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
31	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
32	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
33	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
34	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
35	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
36	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
37	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
38	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
39	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
40	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
41	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院
42	职业教育	“工匠学院”数字化转型与产教融合应用示范项目	杭州技师学院



龙游县实验小学与下库小学共建外教同步课堂



“走心驿站”项目入选省中小学心理健康教育典型案例

学习强国

中国学习强国“学习强国”学习平台

打开

菁菁校园 | VR教学：让孩子看见更大的世界

地方平台发布内容

衢州学习平台

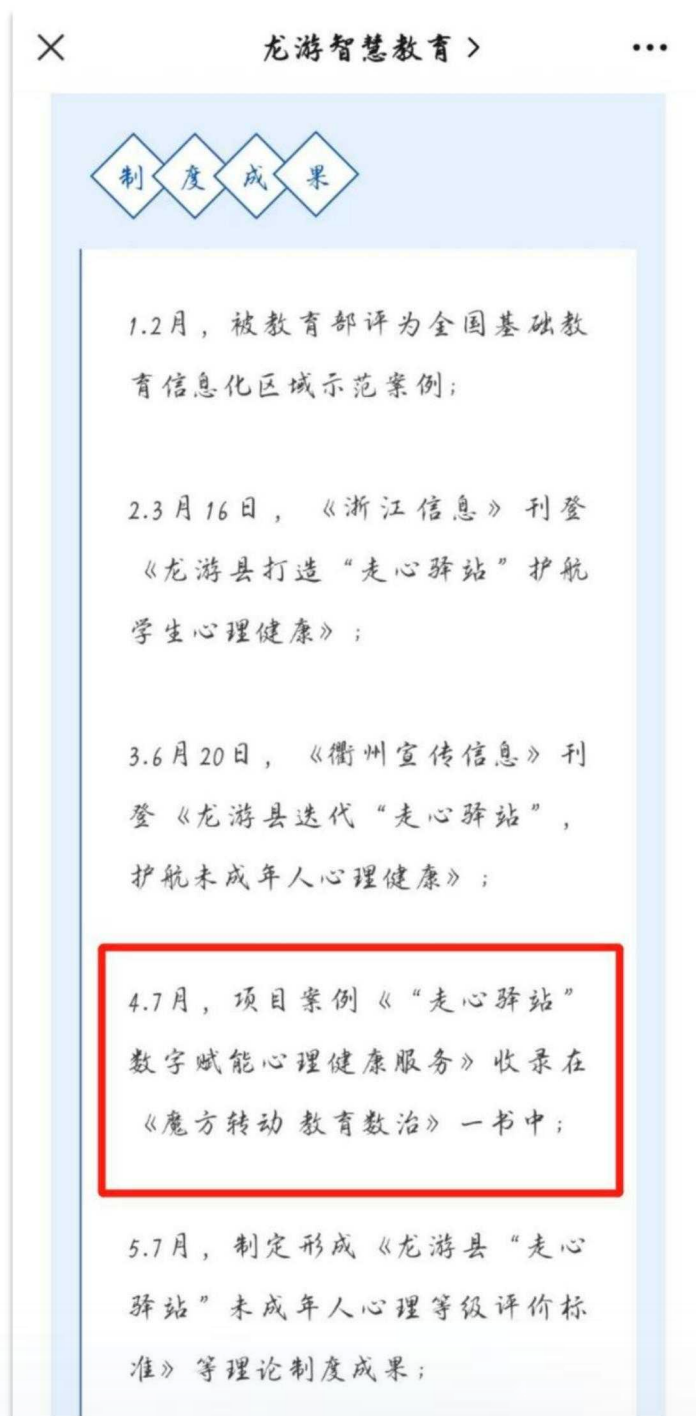
2021-12-22

+ 订阅

只要戴上头盔，就可以从教室一秒“穿越”到地震、火灾、交通事故、溺水事故、疫情暴发等现场，并且体验紧张逼真的“逃生”游戏……这样的安全教育课，你想上一次吗？

从2020年9月份开始，龙游县下库小学斥资20万元改造VR教室，引进VR设备，并尝试将其用于安全教育、心理教育等教学领域。

8. 项目案例《“走心驿站”数字赋能心理健康服务》收录在《魔方转动 教育数治》一书



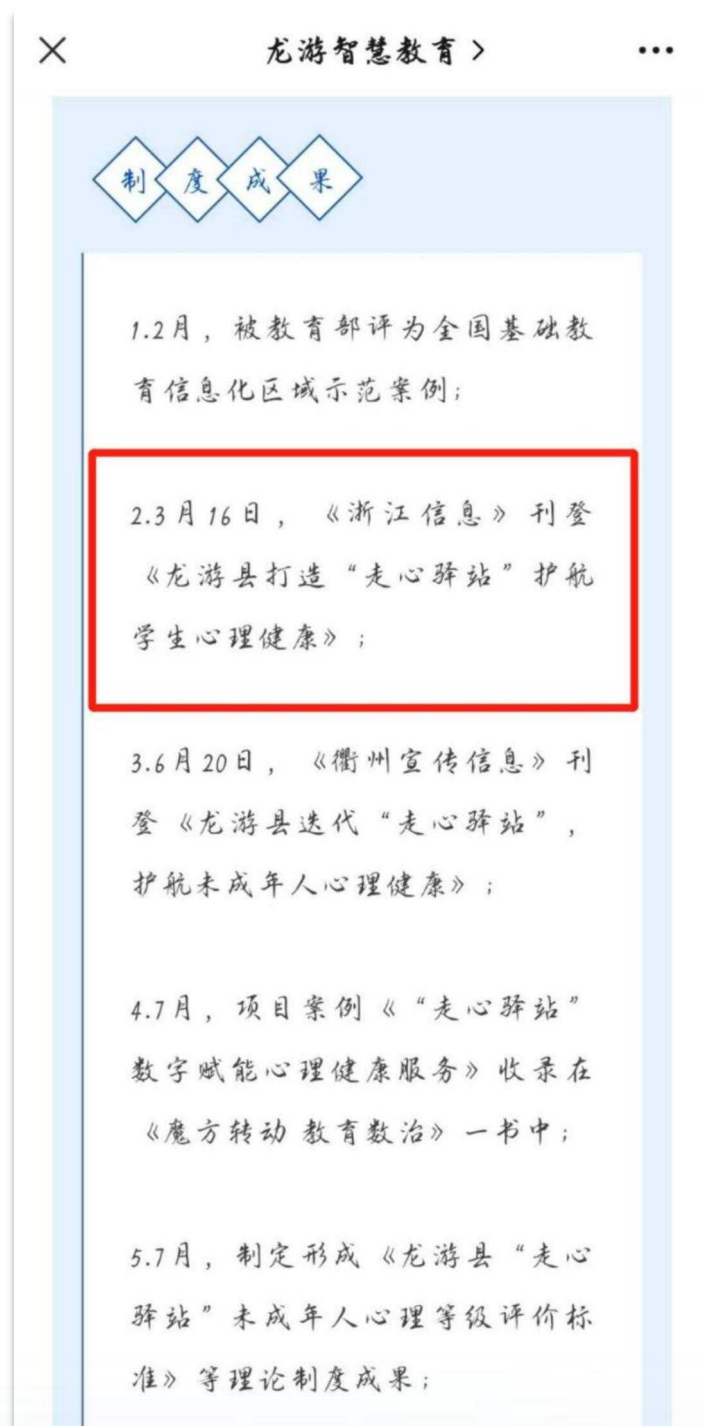
9. 中国教育报对浙江师范大学与龙游县、桐乡市、浦江縣和乐清市的心理健康教育数字化改革进行报道。



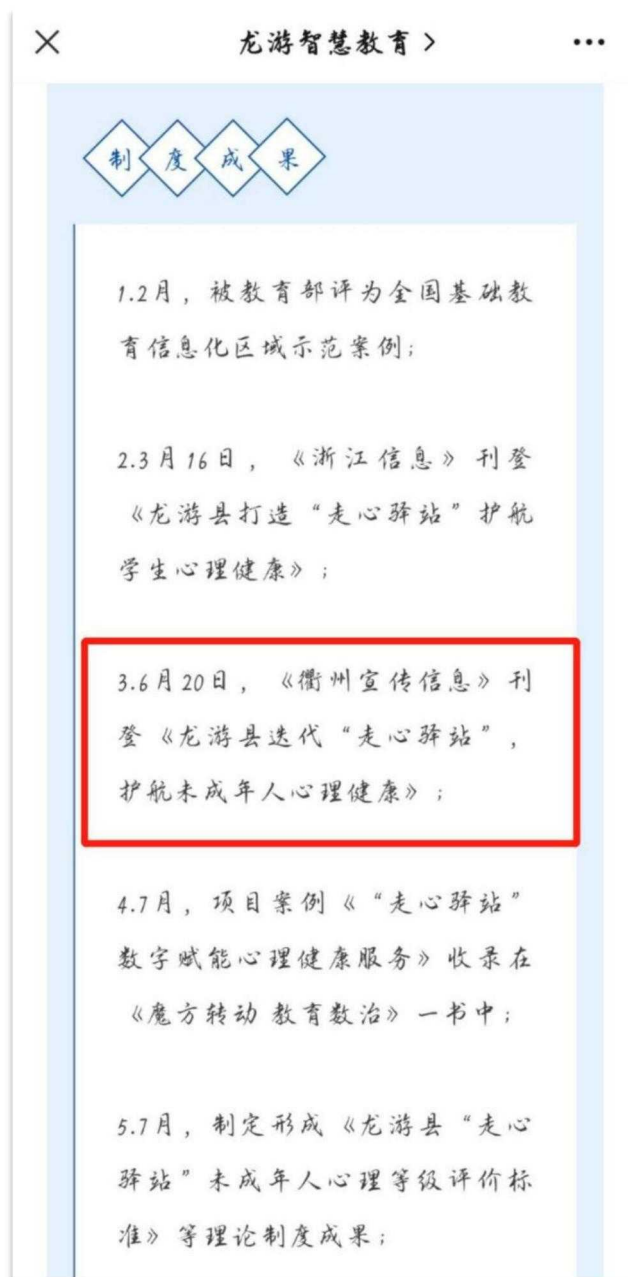
10. 浙江教育报对龙游县“走心”的服务最“暖心”——整县域推进青少年心理健康服务的龙游探索进行了报道。



11. 《浙江信息》刊登《龙游县打造“走心驿站”护航学生心理健康》



12. 《衢州宣传信息》刊登《龙游县迭代“走心驿站”，护航未成年人心理健康》



13. 《衢州日报》教育版刊登“走心驿站”文章《龙游县“走心驿站”与孩子走心相伴》



15. 文章《区域心理健康服务体系构建与实践的探索》发表在《中国民族教育》

区域心理健康服务体系构建与实践

路茂方, 杨尔娟, 吴晓璐

引用格式 转发 收藏

【作者机构】浙江省桐乡市教育局; 浙江省桐乡市教育局基教科; 浙江师范大学

【来源】《中国民族教育》2022年第11期 P49-52页

【分类号】G63

【分类导航】文化、科学、教育、体育 > 教育 > 中等教育

【关键词】习近平新时代中国特色社会主义思想 立德树人 浙江省桐乡市 心理健康服务体系 构建与实践 中小学生学习心理健康教育 中小学生学习心理健康教育 行动纲要

【摘要】切实加强新时代中小学生学习心理健康教育,促进中小学生学习平安健康成长,是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实浙江省教育大会精神,落实立德树人根本任务,贯彻心理健康教育根本要求,为全面落实《“健康中国2030”规划纲要》《健康浙江2030行动纲要》精神,进一步加强中小学生学习心理健康教育工作,浙江省桐乡市教育局近年来积极探索区域心理健康服务体系构建与实践的有效路径与经验。



二、学校心理健康教育服务现状调查问卷

您好！我们是浙江师范大学心理学研究团队，我们希望了解人们关于中小学心理健康教育方面问题的看法。我们承诺问卷调查只作为科研用途，不会向他人透露您的个人信息，请您填写您的真实想法或感受。

1.您的身份是（可多选）

- A.教育部门工作人员
- B.非教育部门工作人员
- C.校长
- D.班主任
- E.心理健康专职教师
- F.家长
- G.学生

2.您所在地区是否属于以下 26 县（淳安县、永嘉县、平阳县、苍南县、文成县、泰顺县、武义县、磐安县、柯城区、衢江区、江山市、常山县、开化县、龙游县、三门县、天台县、仙居县、莲都区、龙泉市、青田县、云和县、庆元县、缙云县、遂昌县、松阳县、景宁畲族自治县）

- A.是
- B.否

3.您认为心理健康教育对于学生来说重要吗

- A.重要
- B.不重要

4.您认为心理健康教育服务的对象是

- A.有严重心理问题的学生
- B.所有学生

5.您认为心理健康教育工作会影响学生的学习成绩吗

A.会，他会占用学生的学习时间

B.不会

C.能够更好的促进学生的学习

6.您认为现在的学生会主动寻求心理老师的帮助吗

A.会

B.不会

C.不了解

7.您认为学校现在的学生心理健康调查是否精准

A.一点都不精准

B.有点精准

C.不确定

D.比较精准

E.非常精准

8.您认为当前测量学生的心理健康状况的问卷是否科学

A.科学

B.不清楚

C.不科学

9.您以往是否参加过专业的心理健康教育培训

A.是

B.否

10.您认为心理健康教育工作者的工作压力大么

- A.一点都没有压力，非常轻松
- B.有点压力
- C.不清楚
- D.压力比较大
- E.压力非常大

11.您认为现在心理健康教育工作者的待遇如何？

- A.没有待遇
- B.较低
- C.中等
- D.较高
- E.很高

12.您认为学校能给不同心理健康状况学生提供个性化服务吗

- A.可以
- B.基本可以
- C.基本不可以
- D.不可以

13.心理健康教育主要是学校的责任

- A.完全同意
- B.比较同意
- C.完全不同意

14.您接触到的心理健康教育相关知识有（可多选）

- A.认识心理异常现象
- B.学会情绪调节
- C.学会人际交往

- D.掌握自制力
- E.适应新环境
- F.应对学业压力

15.您认为心理健康教育最大的作用是什么（可多选）

- A.消除学生负面情绪
- B.提高学生学习成绩
- C.促进学生更好的成长发展

16.您认为学生不主动寻求帮助的主要原因可能是（可多选）

- A.担心被贴标签
- B.心理健康教育没用
- C.其他（填写文字）

17.您认为无法精准识别心理危机学生的主要原因是（可多选）

- A.使用的问卷不科学
- B.学生填写不认真
- C.没有综合考虑各种因素
- D.其他（）

18 对于社会中学生自杀自残情况，您认为问题在于（可多选）

- A.心理测评无法精准识别心理危机学生
- B.对心理危机学生无法做到智能化干预
- C.对学生心理健康重视程度不够
- D.一些“成绩论”的观点导致越来越多的学生出现心理问题

19.您认为学生心理健康教育工作的难点是什么（可多选）

- A.精准识别心理危机学生
- B.智能干预学生心理问题

C.矫正部分人对心理健康的错误认识

20.您了解学生心理健康状况的途径是（可多选）

- A.学生的心理量表测验结果
- B.从平时与学生交流中了解
- C.老师的反馈
- D.家长的反馈
- E.人工智能
- F.大数据

21.您获取心理健康教育相关知识的途径是（可多选）

- A.阅读相关书籍
- B.网络平台推送
- C.参与相关系列课程培训
- D.同事、亲朋好友
- E.自学

22.您知道哪些地方能够提供心理健康服务吗（可多选）

- A.学校
- B.社区
- C.心理咨询机构
- D.网络平台
- E.其他

23.您认为推动学校心理健康教育工作有哪些途径（可多选）

- A.利用大数据进行精准识别、智能干预
- B.对相关人员进行定期培训考核
- C.家校社联动

D.其他

24.您认为影响老师参与心理健康教育工作的主要原因是（可多选）

- A.缺乏心理健康教育意识
- B.缺乏心理健康教育技能
- C.没有时间精力参与
- D.会影响学生学习成绩

25 您认为影响家长参与心理健康教育工作的主要原因是（可多选）

- A.缺乏心理健康教育意识
- B.缺乏心理健康教育技能
- C.没有时间精力参与
- D.会影响学生学习成绩

三、学校心理健康教育服务现状访谈提纲

(一) 教育部门访谈提纲

教育部门——实地访谈

XX 局长您好！我是走心驿站团队的成员，这里有几个关于小学生心理健康教育方面的问题想向您咨询，访谈内容只作为调研材料，不会向外透露您的信息，为了方便记录访谈结果，您是否介意我对采访内容进行录音呢？

……（进行访谈）

感谢您的配合。祝您身体健康，工作顺利！

访谈内容：

1. 您如何看待目前的区域心理健康教育
2. 您认为教育部门在整个区域心理健康教育中承担什么样的角色
3. 请谈谈教育部门在推进区域心理健康教育时如何进行区域资源整合？
4. 您认为教育部门开展心理健康教育工作的契机在哪？
5. 您认为教育部门在推进心理健康教育工作的未来重点方向是什么？
6. 请谈谈在心理健康教育方面工作的开展中遇到的难点有？根据难点尝试了哪些解决办法

(二) 学校管理者访谈提纲

校长访谈提纲

校长——实地访谈

XX 校长您好！我是走心驿站团队的成员，这里有几个关于小学生心理健康教育方面的问题想向您咨询，访谈内容只作为调研材料，不会向外透露您的信息，为了方便记录访谈结果，您是否介意我对采访内容进行录音呢？

……（进行访谈）

感谢您的配合。祝您身体健康，工作顺利！

访谈内容：

- 1.请您大概介绍一下学校现在的心理健康测评体系？并谈谈您的看法？
- 2.您对学校未来3年的心理健康教育规划是怎样的？可以从“心理健康教育测评工作”、“心理健康教育要达到的目标”、“心理健康教育师资建设”等方面展开。
- 3.您校对于心理健康专职教师的工作保障如何？可以从“工作安排”、“薪资待遇”、“晋升评级机制”、“培养发展”等方面展开说明。
- 4.您在开展学校心理健康教育工作时，有哪些难点呢？可以从“心理健康教育专业队伍建设”、“学生学业与心理健康平衡”等方面展开。

班主任访谈提纲

班主任——实地访谈

XX 老师您好！我是走心驿站团队的成员，这里有几个关于小学生心理健康教育方面的问题想向您咨询，访谈内容只作为调研材料，不会向外透露您的信息，为了方便记录访谈结果，您是否介意我对采访内容进行录音呢？

……（进行访谈）

感谢您的配合。祝您身体健康，工作顺利！

访谈内容：

- 1.您认为心理健康教育重要吗？对学生后续发展有怎样的影响？
- 2.在您的班级中，心理普测结果为危机的学生在平时学习中的表现如何？
- 3.您在与学生相处交流时，最常遇见的关于心理方面的困扰有哪些？您是如何处理？
- 4.请您回忆一下在处理学生心理健康问题时遇到的最棘手的状况？您当时是如何处理的？
- 5.您在处理学生心理危机事件时，会有其他的顾虑吗？如果有，会有哪些方面顾虑？

17 心理健康专职教师访谈提纲

XX 老师您好！我是走心驿站团队的成员，这里有几个关于小学生心理健康教育方面的问题想向您咨询，访谈内容只作为调研材料，不会向外透露您的信息，为了方便记录访谈结果，您是否介意我对采访内容进行录音呢？

……（进行访谈）

感谢您的配合。祝您身体健康，工作顺利！

访谈内容：

- 1.对比学校中已经发生的学生自杀自残事件和心理普测结果，谈谈您的看法。
- 2.您在学校的日常工作包括哪些？
- 3.作为心理健康教育的专职老师，您认为它相比于其他任课的待遇是怎么样
的？比如工资待遇、职业晋升等
- 4.您在学校会有接受专业技能培训的机会吗？如果有，频率如何？
- 5.如果有可能的话，您希望学校再提供一些怎样的条件使您的工作更有发展
性？

(三) 家长访谈提纲

XX 家长您好！我是走心驿站团队的成员，这里有几个关于孩子心理健康教育方面的问题想向您咨询，访谈内容只作为调研材料，不会向外透露您的信息，为了方便记录访谈结果，您是否介意我对采访内容进行录音呢？

……（进行访谈）

感谢您的配合。祝您身体健康，工作顺利！

访谈内容：

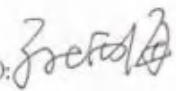
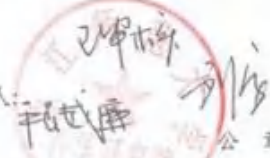
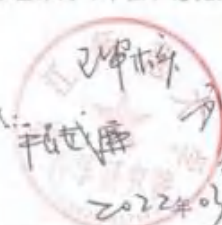
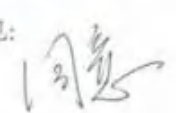
- 1.您是否认为孩子的成绩决定他的未来？如果不是，您认为还有哪些因素很重要呢？
- 2.您认为什么情况下需要对孩子进行心理健康教育？
- 3.您在与孩子交流时有无做到相互理解（您觉得您有做到理解孩子吗？您觉得孩子有做到理解您吗？），如果不能做到相互理解您觉得是什么导致的呢？
- 4.您与孩子之间产生过比较大的矛盾吗，您当时是怎么试着去解决的？
- 5.您希望通过什么样的方式进一步了解孩子的心理健康状况？

四、项目合同

衢州市龙游县项目合同

浙江师范大学合同审签单

编号: HX22052

合同名称	龙游县教育局走心驿站专家团队服务采购		类别	
甲方	龙游县电化教育中心	乙方	浙江师范大学	
合同摘要: 本项目为龙游县教育局走心驿站专家团队服务采购项目, 主要基于“走心驿站”项目开展规划报告论证服务、调研评估驻场服务、标准方案专题服务、成果撰写推广服务等。 合同金额: 60 万元(人民币) 研究期限: 2022 年 3 月 10 日至 2024 年 3 月 9 日				
合同研究内容真实、合法、可行。 项目负责人(签名):  年 月 日				
归口管理部门(单位)意见:		审计处意见:		
经办人:  公章:  2022年3月08日		经办人:  公章:  2022年3月08日		
分管校领导意见:  签名:  年 3 月 8 日				

- 注: 1. 本单适用于 30 万(含)以上 100 万以下横向科研合同审签使用。
2. 摘要部分应写明合同双方名称、标的物数量和金额、合同期限等主要内容。
3. 个人科研项目合同需项目负责人在会签单位栏进行真实性、合法性、可行性承诺并签名。
4. 本表一式二份, 1 份由归口管理单位归档, 1 份由学校办公室留存。

科研诚信承诺书

浙江师范大学受龙游县电化教育中心委托，指定本人作为项目负责人承担龙游县教育局走心驿站专家团队服务采购横向项目的研究，签订横向项目合同，本人代表项目组就该项目研究的相关事项承诺如下：

一、项目研究经费按合同金额全额汇入合同指定账户，按照浙江师范大学科研经费管理办法使用。

二、按照合同约定全面履行合同义务。

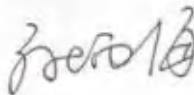
三、遵纪守法，不行贿、不索贿。

四、遵守学术规范，恪守职业道德。

五、合同履行过程中如签订补充协议的，应经学校审核确定。

六、因本人或项目组成员违反合同约定，造成委托人或第三人损失的，由本人或项目组成员自行承当相应法律责任。如学校因此承担了法律责任的，有权向本人或项目组成员全额追偿。

项目负责人签名：



2022年03月08日

57

政府采购中标（成交）通知书

采购项目	龙游县教育局走心驿站专家团队服务采购	编号	LYJY2022003
采购内容	走心驿站专家团队服务采购	数量	详见招标文件
成交单位	浙江师范大学	成交价	600000 元
采购单位	龙游县电化教育中心		
采购单位意见			
招标代理意见			
备注			

项目信息及项目组成员情况

项目名称	龙游县教育局走心驿站专家团队服务采购			
项目归属	所属单位		所属学科	
	浙江师范大学教师教育学院		心理学	
项目组成员：				
序号	姓名	职称	所在单位	任务分工
1	孙炳海	教授	浙江师范大学研究生院	负责人
2	李伟健	教授	浙江师范大学	指导专家
3	陈海德	副教授	浙江师范大学教师教育学院	指导专家
4	褚晓伟	副教授	浙江师范大学教师教育学院	指导专家
5	谢瑞波	副教授	浙江师范大学教师教育学院	指导专家
6	孙琪	讲师	浙江师范大学教师教育学院	指导专家
7	查亮亮	讲师	浙江师范大学教师教育学院	指导专家
8	赵轩	博士生	浙江师范大学继续教育学院	指导专家
9	孙长康	硕士生	浙江师范大学教师教育学院	指导专家
10	虞夏骏	博士生	浙江师范大学教师教育学院	指导专家
11	张孟懿	博士生	浙江师范大学教师教育学院	指导专家

说明：（1）学科按教育部一级学科填写；

（2）项目组成员可以包含一定数量的学生，并在“职称”栏中填写“博士生”“硕士生”“本科生”等。

项目负责人签名：

2022年3月8日

合同

浙江省政府采购合同指引

项目名称：龙游县教育局走心驿站专家团队服务采购

项目编号：LYJY2022003

甲方：龙游县电化教育中心

乙方：浙江师范大学

一、说明

1. 合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2. 制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国民法典》。

二、成交金额

本合同金额为（大写）：陆拾万元整（小写¥600000元）人民币。

三、服务和保密要求

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权及产权担保

乙方保证所提供的知识产权的软件产品为自主开发或拥有，货物是全新产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。乙方保证交付的货物所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵且全新的货物产品。

五、转包或分包

1. 本合同范围的货物和服务，应由乙方直接承接服务供应，不得向他人转让，也不得肢解后分别向他人转让。

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物和服务转包或分包给他人供应。

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

六、服务期限

从 2022 年 3 月 10 日至 2024 年 3 月 9 日止。



七、服务内容

（一）规划报告论证服务

1.乙方组织专家评估“走心驿站”定位、功能、运维、成效，于协议签订之日起3个月内形成一份不少于5000字的规划报告（含“走心驿站”整体项目论证意见、彩虹码命名理论支撑意见、彩虹码综合赋分标准意见、线下场所心理健康硬件设备配备必要性意见）

（二）调研评估驻场服务

1.甲乙双方自协议签订后每个季度召开1-2次项目评估诊断会议，乙方每半年提供一份不少于2000字的整改意见书；

2.乙方每年选派一批应用心理专业团队驻场开展心理健康教育理论与实践调研指导，并参与指导甲方访谈评估工作；

3.乙方每年向甲方提供1-2次心理健康专题报告讲座。

（三）标准方案专题服务

1.针对龙游县心理健康工作与“走心驿站”融合运行情况，乙方研制心理健康各层面教师心育培训标准与方案，并于协议签订后2个月内提供给甲方；

2.乙方在甲方现有的“走心驿站”整体实施方案基础上，指导甲方优化、细化方案，修改完成1份有一定操作性且可推行的县域工作实施方案。

3.乙方指导甲方提炼两本手册：一是用于学校人员的工作手册，二是用于家长的学习手册。

（四）成果撰写推广服务

1.甲乙双方共同总结“走心驿站”心理健康教育数字化改革经验，由乙方撰写提供给甲方一份不少于3000字参阅报告，供相关领导参阅；

2.协议期内，乙方根据甲方工作实施的阶段情况或甲方提供的文章主题框架，提炼心理健康教育与数字化改革理论文章，并在2家及以上国家级报刊、期刊发表3—5篇，发表署名参照第五项内容。

3.根据需要召开面向全国的推广会议，会议费用由甲方另行预算安排。

（五）成果共享

基于“走心驿站”项目形成的成果为甲乙双方共同研发，报送或发表成果、后期申报各类奖项时均以双方名义共同申报署名。乙方提供成果共享协议一份，经甲方确认后签订，一般认为签订合作协议即视为确认成果共享。

八、资金结算和支付方式

资金结算严格按照合同约定的验收结果标准和方式予以支付。

1.合同签订后1个月内支付合同总金额的50%；

2.其余在服务期满后15天内经甲方确认无明显服务质量问题后付清余款（不

计息)。

乙方必须提供给甲方合法、有效的正规增值税发票,否则甲方有权延期付款,直至收到乙方相应正规增值税发票为止。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。(须按照甲方要求开具相应的发票)

十、项目经费管理

项目经费按照浙江师范大学科研项目经费管理办法使用,不另作约定。

十一、合同修改与解除

1.本合同供需双方的任何一方无权对合同内容进行修改,本合同如需修改,必须达成书面协议,并作为该合同的有效组成部分。

2.协议期满后,如甲方需乙方延续提供服务的,乙方应按照本协议要求继续提供相关服务,服务费用按照本协议约定金额的日均费用计算,延续服务期不得超出本协议合同款项的10%,服务费由甲方在延续服务期满后一个月内一次性支付乙方。

3.合同可以经双方协商一致解除,或按照《民法典》的规定单方解除。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受服务的,甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的,每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的,甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.在服务质量保证期内,乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，龙游久圆工程管理有限公司加盖鉴证章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，龙游久圆工程管理有限公司执一份。

甲方(盖章):

法定代表人或委托

代理人(签字或盖章):

地址:

联系方式:

签订日期:2022年3月9日

乙方(盖章):

法定代表人或委托

代理人(签字或盖章):

地址:

联系方式:合同专用章

签订日期:2022年3月9日

合同鉴证方:龙游久圆工程管理有限公司

鉴证日期:2022年3月9日

五、专家推荐

(一) 华东师范大学周晓林教授推荐信

D1. 推荐者情况及对作品的说明

推 荐 者 情 况	姓 名	周晓林	性别	男	年龄	59	职称	教授
	工作单位	华东师范大学心理与认知科学学院						
	通讯地址	上海市普陀区中山北路 3663				邮政编码	200063	
	单位电话	010-62232923				住宅电话	010-82865468	
推荐者所在 单位签章		 2023年8月6日  (签章)						
请对申报者申报情况的 真实性作出阐述		情况属实，确实有效。						
请对作品的意义、技 术水平、适用范围及 推广前景作出您的评 价		“走心驿站”结合数字赋能与心理赋能，将心理学应用于实际， 推广至全省，带动全省心理健康顶层体制建构科学化、底层服务 方式专业化						
其它说明		项目团队提出了很好地想法，真正解决当前社会存在着的问题， 并积极参与各项工作开展，特此推荐						

说明：

1. 由推荐者本人填写；
2. 推荐者必须具有高级专业技术职称，并是与申报作品相同或相关领域的
专家学者或专业技术人员（教研组集体推荐亦可）；
3. 推荐者填写此部分，即视为同意推荐；
4. 推荐者所在单位签章仅被视为对推荐者身份的确认。

(二) 南开大学乐国安教授推荐信

D2. 推荐者情况及对作品的说明

推荐者情况	姓 名	乐国安	性别	男	年龄	78	职称	教授
	工作单位	南开大学周恩来政府管理学院						
	通讯地址	天津市津南区同砚路 38 号				邮政编码	300350	
	单位电话	022-23500327				住宅电话		
推荐者所在单位签章	同意 							
请对申报者申报情况的真实性作出阐述	情况属实，真实有效							
请对作品的意义、技术水平、适用范围及推广前景作出您的评价	“走心驿站”做到了心理健康服务的数字化与智能化，不仅重视风险因子，更从正向赋能的角度关注学生的积极心理素质，打造全方位、多角度的智能化服务体系，做到预防全、识别准、干预早。							
其它说明	项目团队提出了很好地想法，真正解决当前社会存在的问题，并积极参与各项工作开展，特此推荐。							

说明：

1. 由推荐者本人填写；
2. 推荐者必须具有高级专业技术职称，并是与申报作品相同或相关领域的专家学者或专业技术人员（教研组集体推荐亦可）；
3. 推荐者填写此部分，即视为同意推荐；
4. 推荐者所在单位签章仅被视为对推荐者身份的确认。

知网个人查重服务报告单(简洁)

报告编号:BC202304062013541127520919

检测时间:2023-04-06 20:13:54

篇名:数“智”赋能的心理健康教育服务新模式—基于浙江百县千校的调研

作者:朱锋;杨婧婧;吴晓璐;许海晗;武莹;朱思雨;李静;柳诗颖;封佳燕;王怡尧

检测类型:其他

比对截止日期:2023-04-06

检测结果

去除本人文献复制比: 6.5%

去除引用文献复制比: 5.7%

总文字复制比: 6.5%

单篇最大文字复制比: 2.5% (用好大数据, 打造学生的“健康管家”)

重复字符数: [1616]

单篇最大重复字符数: [617]

总字符数: [24704]

6.5% (627)	6.5% (627)	数“智”赋能的心理健康教育服务新模式—基于浙江百县千校的调研_第1部分 (总9614字)
3% (260)	3% (260)	数“智”赋能的心理健康教育服务新模式—基于浙江百县千校的调研_第2部分 (总8626字)
11.3% (729)	11.3% (729)	数“智”赋能的心理健康教育服务新模式—基于浙江百县千校的调研_第3部分 (总6464字)

1. 数“智”赋能的心理健康教育服务新模式—基于浙江百县千校的调研_第1部分

总字符数: 9614

相似文献列表

去除本人文献复制比: 6.5% (627)

去除引用文献复制比: 6.4% (616)

文字复制比: 6.5% (627)

1	C2C模式下生鲜电商平台消费者购买决策影响因素研究 郭梦威 - 《大学生论文联合比对库》 - 2020-05-11	2.9% (277) 是否引证: 否
2	线上拖延对消费者购买行为的影响—以大学生为例 张得朋 - 《大学生论文联合比对库》 - 2020-05-31	2.7% (255) 是否引证: 否
3	北京西站客运服务差异化研究 戚艺璇 - 《大学生论文联合比对库》 - 2019-05-17	2.5% (245) 是否引证: 否
4	12586783_傅征南_运动类APP对大学生体育锻炼习惯的影响 傅征南 - 《大学生论文联合比对库》 - 2018-04-30	2.1% (200) 是否引证: 否
5	民航飞行学员心理应激状况及管理策略 杨骐羽 - 《大学生论文联合比对库》 - 2021-04-23	2.0% (196) 是否引证: 否
6	1502664842_杨文博_企业知识共享的影响因素及其对创新绩效的影响 杨文博 - 《高职高专院校联合比对库》 - 2019-06-01	1.9% (183) 是否引证: 否
7	网络购物的刺激对冲动性购物的影响, 以情绪为中介 应智炜 - 《大学生论文联合比对库》 - 2020-04-12	1.6% (152) 是否引证: 否
8	网络购物的刺激对冲动性购物的影响, 以情绪为中介 应智炜 - 《大学生论文联合比对库》 - 2020-04-13	1.6% (152) 是否引证: 否
9	苏卓 B站用户体验调查研究 苏卓 - 《大学生论文联合比对库》 - 2021-05-19	1.5% (146) 是否引证: 否
10	学生在线学习行为与学习效果的研究: 以网络课程教学为例 吴慧 - 《大学生论文联合比对库》 - 2020-05-08	1.5% (145) 是否引证: 否
11	学生在线学习行为与学习效果的研究: 以网络课程教学为例 吴慧 - 《大学生论文联合比对库》 - 2020-05-15	1.5% (145) 是否引证: 否

12	2016004271_姜鑫_HAPL铲头机设计 姜鑫 - 《大学生论文联合比对库》 - 2020-04-27	1.5% (141) 是否引证: 否
13	201708060022-付家明-退役军人就业选择影响因素与工作满意度研究-晁玉方 付家明 - 《大学生论文联合比对库》 - 2021-06-03	1.5% (141) 是否引证: 否
14	网络购物的刺激对冲动性购物的影响,以情绪为中介 应智炜 - 《大学生论文联合比对库》 - 2020-05-06	1.4% (139) 是否引证: 否
15	202004092011154091_无作者_大学生利用网络社交平台风险的影响因素分析-- 无作者 - 《大学生论文联合比对库》 - 2020-04-09	1.4% (138) 是否引证: 否
16	2016010010132-林思梅-潘秀珍-WK企业基层管理人员培训效果评价及优化对策研究 林思梅 - 《大学生论文联合比对库》 - 2020-06-09	1.4% (136) 是否引证: 否
17	基于参与动机的大学生赛事志愿者管理研究 张楠 - 《大学生论文联合比对库》 - 2020-05-17	1.4% (135) 是否引证: 否
18	基于同屏技术的农村小学中年级语文写作的精准教学研究 徐晓玲(导师:罗刚) - 《广西师范大学硕士论文》 - 2020-06-30	1.4% (130) 是否引证: 否
19	1513491223+张方亮+管理学院 - 《大学生论文联合比对库》 - 2019-05-14	1.3% (128) 是否引证: 否
20	消费者对新中式红木家具的购买意愿及影响因素分析——以苏州市荡东家具城为例 陈杰 - 《大学生论文联合比对库》 - 2021-05-12	1.3% (123) 是否引证: 否
21	消费者对新中式红木家具的购买意愿及影响因素分析——以苏州市荡东家具城为例 陈杰 - 《大学生论文联合比对库》 - 2021-05-13	1.3% (123) 是否引证: 否
22	1610300106 张楠 - 《大学生论文联合比对库》 - 2020-05-28	1.3% (122) 是否引证: 否
23	201708060022-付家明-退役军人就业选择影响因素与满意度研究-晁玉方 付家明 - 《大学生论文联合比对库》 - 2021-06-15	0.9% (83) 是否引证: 否
24	协同理论视角下校企合作产教融合动力机制的构建 关宏;刘嘉琪; - 《中外企业文化》 - 2022-08-25	0.8% (81) 是否引证: 否
25	基于CNN-LSTM神经网络的在校大学生教育成果预测 杨钰懋;戎小凤; - 《重庆电力高等专科学校学报》 - 2023-02-28	0.8% (78) 是否引证: 否
26	17300696007_爱丽娜_修改定稿 爱丽娜 - 《大学生论文联合比对库》 - 2021-06-01	0.7% (65) 是否引证: 否
27	浙江数字化中药标本平台建设探索与实践 陆静娴;陈浩;戚雁飞;郑成;陈碧莲;周霖;陈勇; - 《中国现代应用药学》 - 2022-11-15	0.5% (49) 是否引证: 否
28	非洲来华留学生教育管理研究 狄伟锋(导师:杨天平) - 《浙江师范大学博士论文》 - 2022-06-19	0.5% (44) 是否引证: 否
29	吉林市天主教文化旅游资源开发研究 唐薇(导师:韩宾娜) - 《东北师范大学硕士论文》 - 2012-06-01	0.4% (42) 是否引证: 否
30	中小学心理健康教育问题与对策 晓蕾;怡洁; - 《大众心理学》 - 2005-10-15	0.3% (31) 是否引证: 否

2. 数“智”赋能的心理健康教育服务新模式—基于浙江百县千校的调研_第2部分	总字符数: 8626
相似文献列表	
去除本人文献复制比: 3%(260) 去除引用文献复制比: 1%(89) 文字复制比: 3%(260)	
1 关于高校因精神障碍休学学生复学问题的探讨 鄢玲; - 《华章》 - 2013-10-01	1.1% (98) 是否引证: 否
2 “医教结合”高校心理健康服务工作的探索 毕玉芳; - 《思想理论教育》 - 2013-08-15	1.1% (92) 是否引证: 否
3 医教结合对大学生心理危机预防干预的优势体现	1.1% (92)

	沈丽;薛玲; - 《统计与管理》 - 2016-01-20	是否引证: 否
4	<u>试析我国高校心理咨询的不足及改进措施</u>	1.0% (86)
	郑恩; - 《安徽文学(下半月)》 - 2015-02-25	是否引证: 否
5	<u>我国学校心理健康教育政策的演进与展望</u>	0.9% (74)
	李国强;高芳红; - 《湖南人文科技学院学报》 - 2013-04-28	是否引证: 否
6	<u>精神卫生法视野下高校心理健康教育思考</u>	0.9% (74)
	孟然;廖斌; - 《现代商贸工业》 - 2014-08-01	是否引证: 否
7	<u>论学校社会工作与学校心理咨询的异同</u>	0.9% (74)
	韩闻芳; - 《社会心理科学》 - 2014-12-15	是否引证: 否
8	<u>山东省人大法制委员会关于《山东省残疾预防和残疾人康复条例(草案修改稿)》修改情况的说明——2022年9月21日在山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十八次会议上</u>	0.8% (70)
	崔洪刚; - 《山东省人民代表大会常务委员会公报》 - 2022-09-30	是否引证: 否
9	<u>法律与专业伦理规制下高校心理育人工作研究</u>	0.8% (68)
	任怡; - 《中国轻工教育》 - 2022-12-20	是否引证: 否
10	<u>高校心理咨询伦理的结构与优化——基于Nvivo11的质性分析</u>	0.8% (68)
	卓潇;姚本先; - 《衡水学院学报》 - 2023-02-06	是否引证: 否
11	<u>山东省残疾预防和残疾人康复条例</u>	0.8% (68)
	- 《山东省人民代表大会常务委员会公报》 - 2022-09-30	是否引证: 否
12	<u>中华人民共和国精神卫生法</u>	0.8% (68)
	- 《陕西省人民政府公报》 - 2012-12-15	是否引证: 否
13	<u>中华人民共和国精神卫生法</u>	0.8% (68)
	- 《宁夏回族自治区人民政府公报》 - 2012-12-15	是否引证: 否
14	<u>中华人民共和国精神卫生法</u>	0.8% (68)
	- 《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》 - 2012-11-15	是否引证: 否
15	<u>中华人民共和国精神卫生法</u>	0.8% (68)
	- 《天津市人民代表大会常务委员会公报》 - 2012-12-31	是否引证: 否
16	<u>中华人民共和国精神卫生法</u>	0.8% (68)
	- 《中华人民共和国公安部公报》 - 2012-12-15	是否引证: 否
17	<u>关注心灵成长 普及卫生知识</u>	0.8% (68)
	邓进利;岑智能; - 《家庭科技》 - 2013-06-01	是否引证: 否
18	<u>中华人民共和国精神卫生法</u>	0.8% (68)
	- 《司法业务文选》 - 2012-11-05	是否引证: 否
19	<u>中华人民共和国精神卫生法</u>	0.8% (68)
	- 《慢性病学杂志》 - 2013-01-15	是否引证: 否
20	<u>推进学校心理卫生服务从数据和理论走向行动</u>	0.8% (66)
	陶芳标; - 《中国学校卫生》 - 2021-01-19 15:07	是否引证: 否
21	<u>团体咨询在聋哑青少年心理健康教育中的应用探索</u>	0.8% (66)
	万超;刘伟; - 《绥化学院学报》 - 2014-04-01	是否引证: 否
22	<u>对高校精神疾患类学生的救济思考</u>	0.8% (66)
	闫璐颖;谢玉诚; - 《考试周刊》 - 2015-06-23	是否引证: 否
23	<u>《精神卫生法》规制下的高校心理健康教育工作格局</u>	0.8% (66)
	马喜亭;刘立新; - 《思想理论教育》 - 2017-12-15	是否引证: 否
24	<u>中小学生心理健康发展评估与测评</u>	0.8% (65)
	陈庆荣;汤其凤;安媛媛; - 《江苏教育研究》 - 2023-02-20	是否引证: 否
25	<u>关于创新社会心理服务理念的思考</u>	0.3% (30)
	李子含; - 《品位·经典》 - 2021-04-15	是否引证: 否
26	<u>落红不是无情物 化作春泥更护花——常州市金坛区花山小学“爱”的教育德育品牌建设</u>	0.3% (29)
	赵锁庆; - 《教书育人》 - 2021-01-15	是否引证: 否
27		0.3% (29)

高职生存在的心理问题及救助机制研究 马宁; - 《成都航空职业技术学院学报》 - 2013-12-19		是否引证: 否
3. 数“智”赋能的心理健康教育服务新模式—基于浙江百县千校的调研_第3部分 总字符数: 6464		
相似文献列表		
去除本人文献复制比: 11.3%(729) 去除引用文献复制比: 10.7%(691) 文字复制比: 11.3%(729)		
1	用好大数据, 打造学生的“健康管家” 记者 尹婵萱 通讯员 陈华瑞 钟昕瑾 叶应珩 - 《衢州日报》 - 2021-11-18	9.5% (617) 是否引证: 否
2	广州市花都区宝桑园生态农业发展SWOT分析及营销策略探究 温颖娟;王小平;宋可; - 《现代农业科技》 - 2018-04-08 0	0.6% (38) 是否引证: 否
3	近年来S市未成年人犯罪问题的成因分析及其治理对策研究 谭秀英(导师: 王敏) - 《湖南师范大学硕士论文》 - 2021-06-01	0.5% (32) 是否引证: 否
4	关于“互联网+”时期大学生心理健康教育的探析 汪丹; - 《财富时代》 - 2021-04-25	0.4% (29) 是否引证: 否

- 说明:
1. 总文字复制比:被检测文献总重复字符数在总字符数中所占的比例

2. 去除引用文献复制比:去除系统识别为引用的文献后, 计算出来的重合字符数在总字符数中所占的比例

3. 去除本人文献复制比:去除系统识别为作者本人其他文献后, 计算出来的重合字符数在总字符数中所占的比例

4. 单篇最大文字复制比:被检测文献与所有相似文献比对后, 重合字符数占总字符数比例最大的那一篇文献的文字复制比

5. 复制比按照“四舍五入”规则, 保留1位小数;若您的文献经查重检测, 复制比结果为0, 表示未发现重复内容, 或可能存在的个别重复内容较少不足以作为判断依据

6. 红色文字表示文字复制部分;绿色文字表示引用部分(包括系统自动识别为引用的部分);棕灰色文字表示系统依据作者姓名识别的本人其他文献部分

7. 系统依据您选择的检测类型(或检测方式)、比对截止日期(或发表日期)等生成本报告

8. 知网个人查重唯一官方网站:<https://cx.cnki.net>

浙江省第十八届“挑战杯”课外学术科技作品竞赛

数“智”赋能下的心理健康教 育服务新模式

——基于浙江百县千校的调研

作品类别：哲学社会科学类社会调查报告

作品分类：中国之治